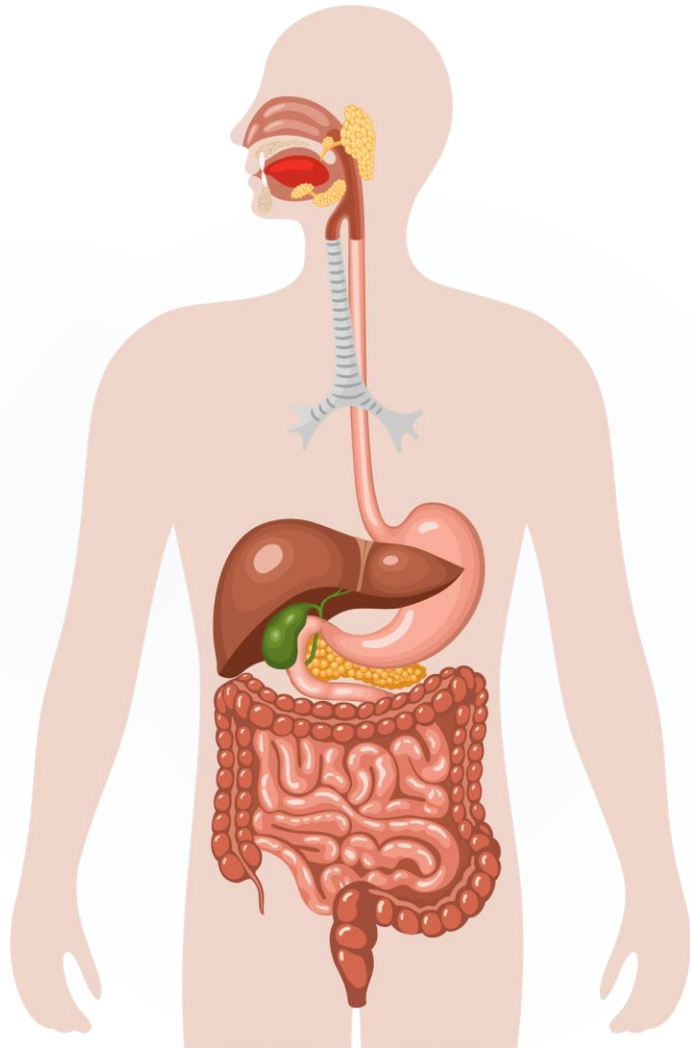




Презентация занятия по теме № 9

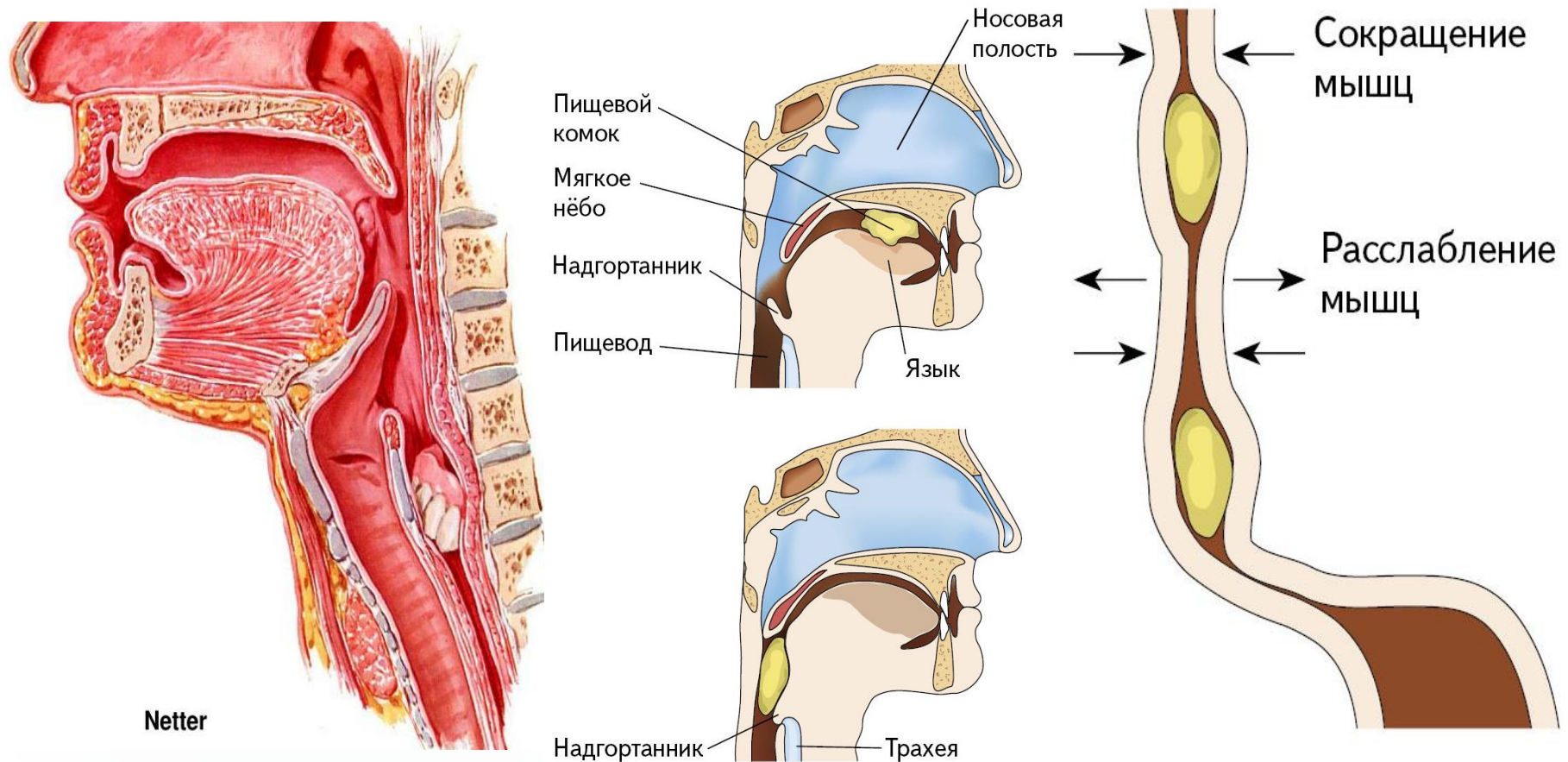
Понятие об основных патологических симптомах при заболеваниях органов пищеварения. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов пищеварения. Оказание неотложной доврачебной помощи. Клизмы.

Общие вопросы о пищеварительной системе



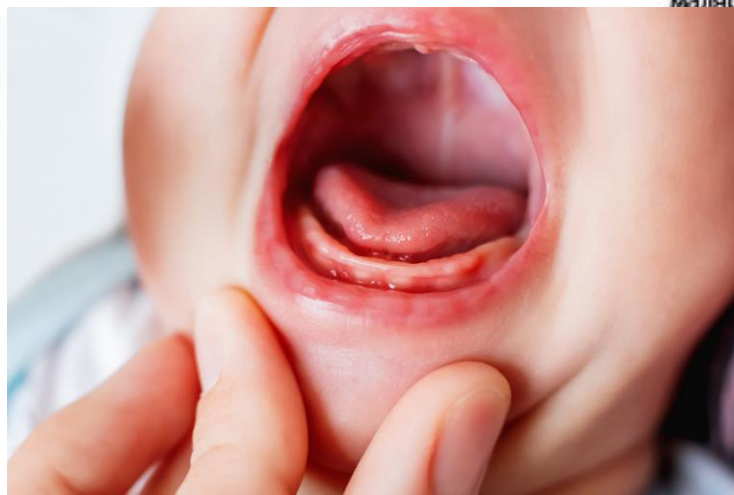
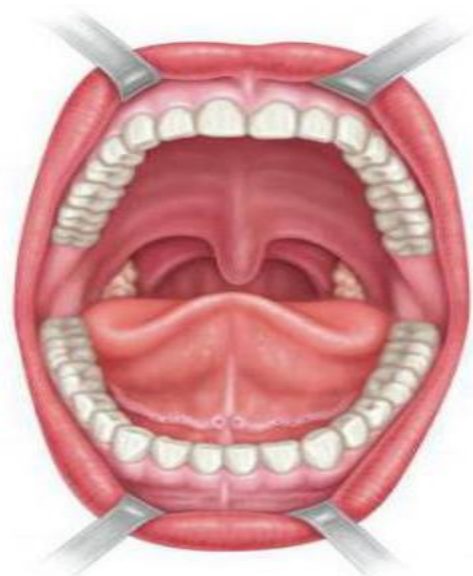
- **Пищеварение** – сложный процесс трансформации принятой пищи, в результате которого компоненты, сохранив энергетическую и пластическую ценность, должны утратить видовую специфичность и приобрести свойство быть усвоенными организмом и включенными в его нормальный обмен веществ.
- **Пищеварительная система** – совокупность органов, включающих пищеварительный тракт (ротовая полость со слюнными железами, глотка, пищевод, желудок, кишечник), поджелудочную железу и печень.
- **Функции пищеварительной системы:**
 - Секреторная;
 - Моторно-эвакуаторная (двигательная);
 - Всасывательная;
 - Экскреторная (выделительная);
 - Инкреторная (гуморальная, эндокринная);
 - Защитная;
 - Рецепторная;
 - Гемопоэтическая (внутренний фактор Кастла)

Прием пищи, жевание, глотание



Netter

Ротовая полость

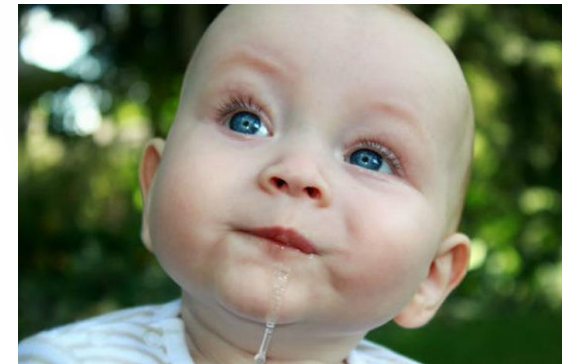


Десневые валики – дублированная слизистая оболочка с богатой сетью эластических волокон, образует гребни, обеспечивающие функцию сосания

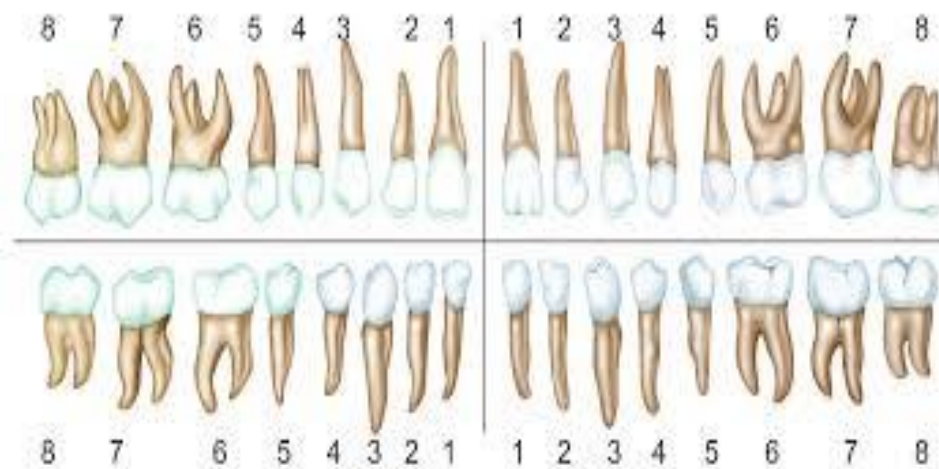
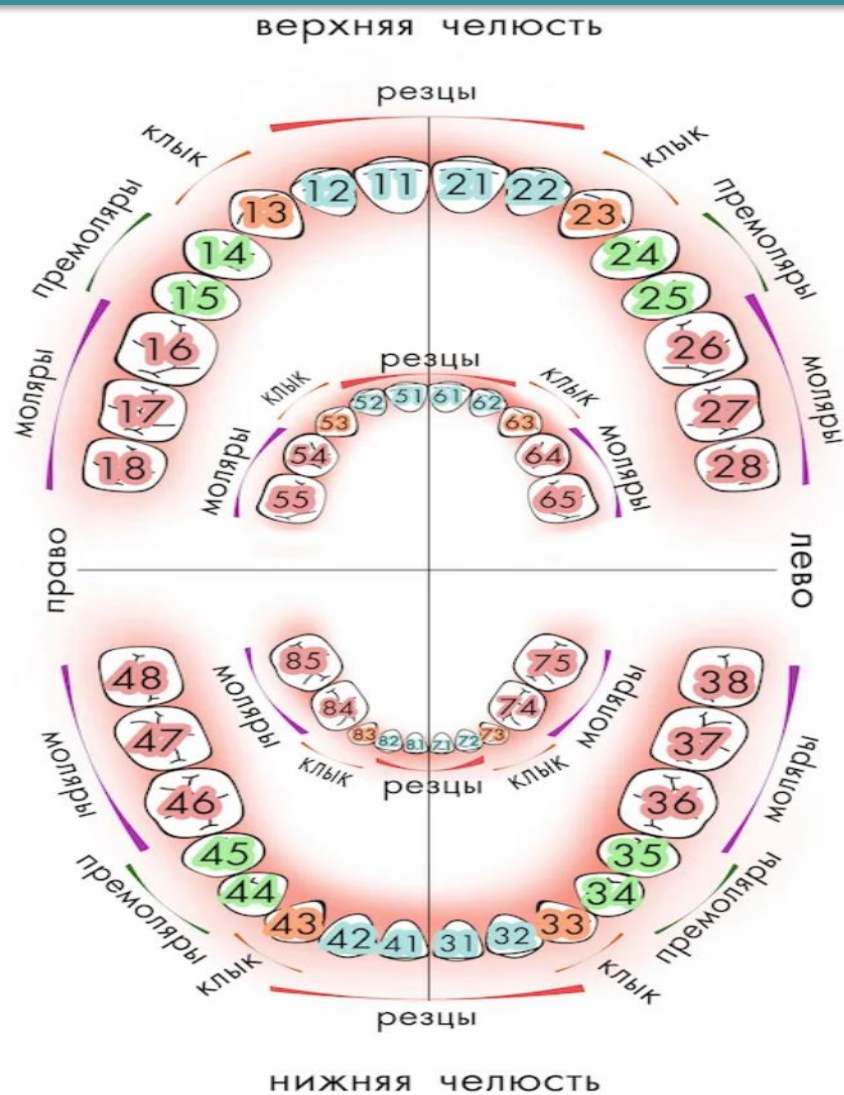
Особенности ротовой полости у детей



- ▶ Полость рта относительно мала и полностью заполнена языком.
- ▶ Язык короткий, толстый. При сосании создает в полости рта отрицательное давление.
- ▶ Слизистая оболочка нежная, суховатая, богата кровеносными сосудами. Эпителий состоит из 2-3 слоев клеток, что приводит к легкой ранимости слизистой.
- ▶ Губы и щеки сравнительно толстые, с достаточно развитой мускулатурой и плотными жировыми комочками Биша щек, содержащими бурый жир.
- ▶ Комочки Биша являются «энергетическим депо» и сохраняют каркас щек, способствуя поддержанию эффективного отрицательного давления в полости рта, достигающего 60-140 мм. вод. ст.



Зубы



Глотание

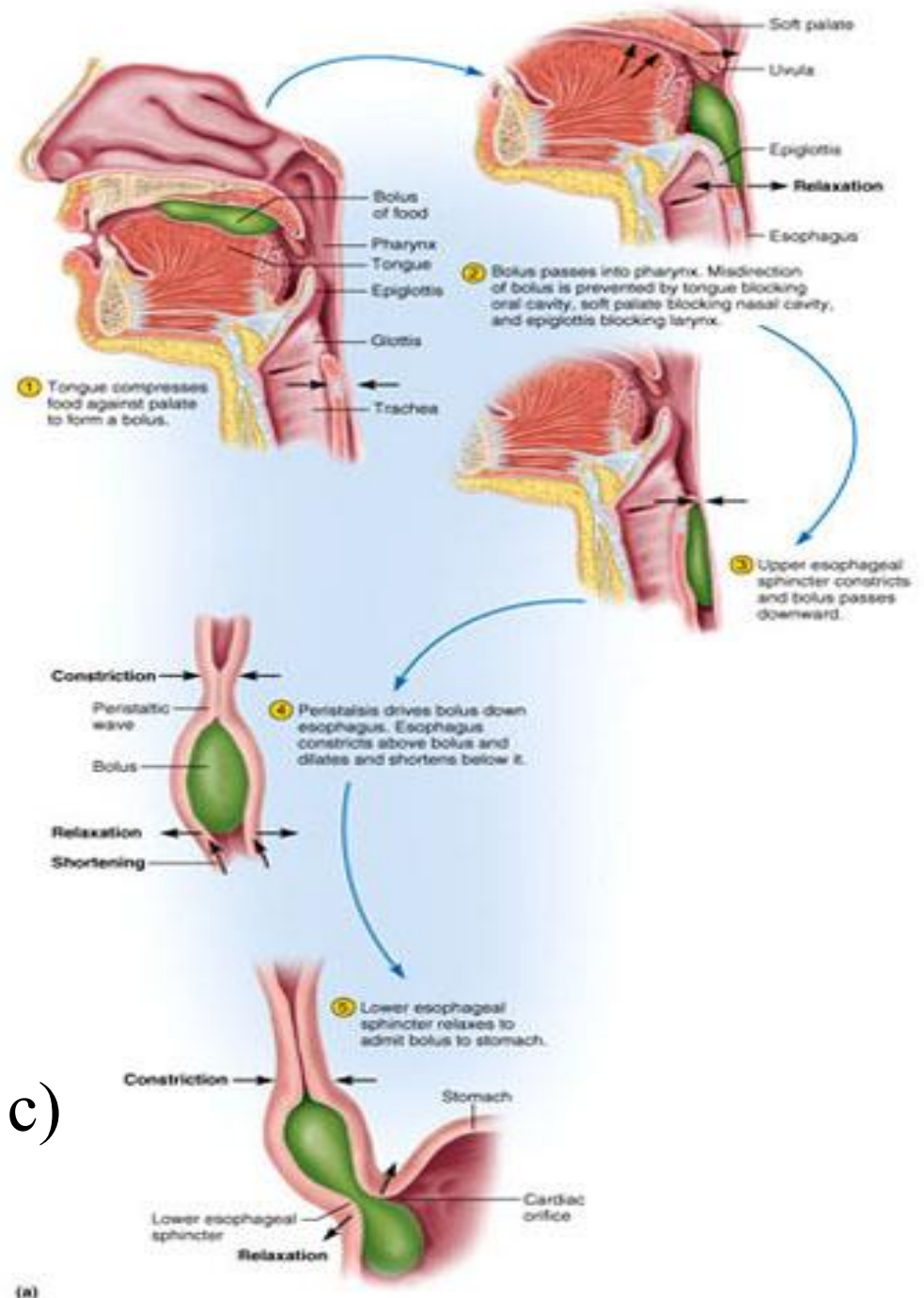
1. Оральная фаза (3-10 с)

- ▶ Гипосаливация
- ▶ Заболевания слизистой оболочки полости рта
- ▶ Патология языка
- ▶ Нарушение иннервации

▶ Глоточная фаза (2-3 с)

- ▶ Нарушение иннервации

▶ Пищеводная фаза (6-15 с)



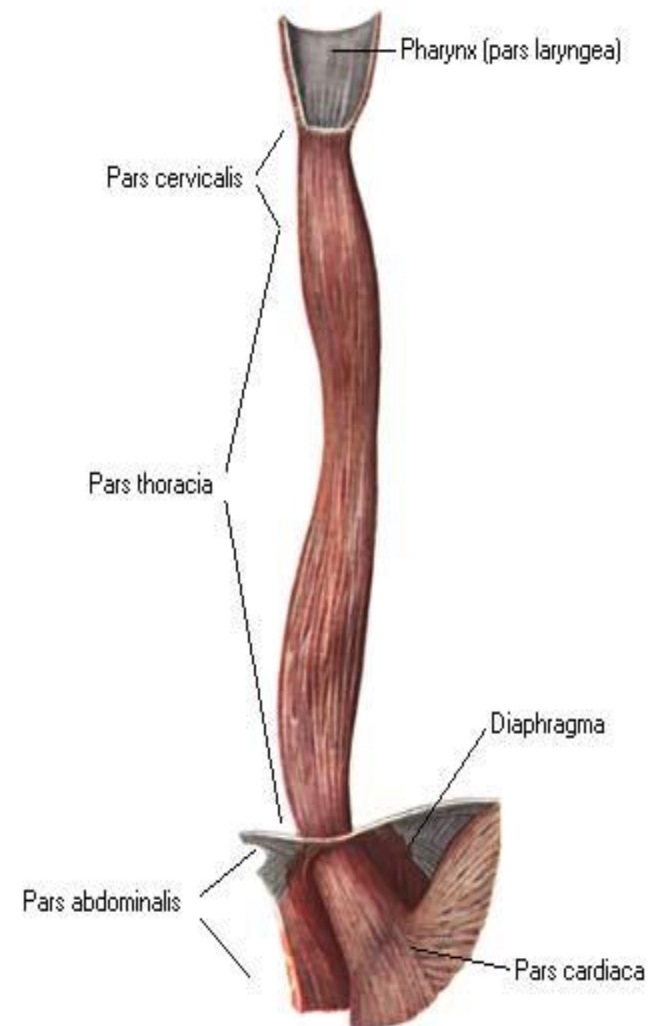
Пищевод



Длина пищевода в зависимости от возраста
(Воронцов И.М., Мазурин А.В., 2009)

Возраст, лет	Длина, см	Расстояние от зубов до входа в желудок, см
Новорожденный	8–10	16–20
1	12	20–22
2	13	22,5–24
3	16	26–27,9
10	18	27–33
15	19	34–36
Взрослые мужчины	25 (23–30)	40
Взрослые женщины	23 (20–26)	40

Показатель «расстояние от зубов до входа в желудок» может быть также рассчитан по формуле: $L = 20 + n$,
где n - возраст ребенка (лет).

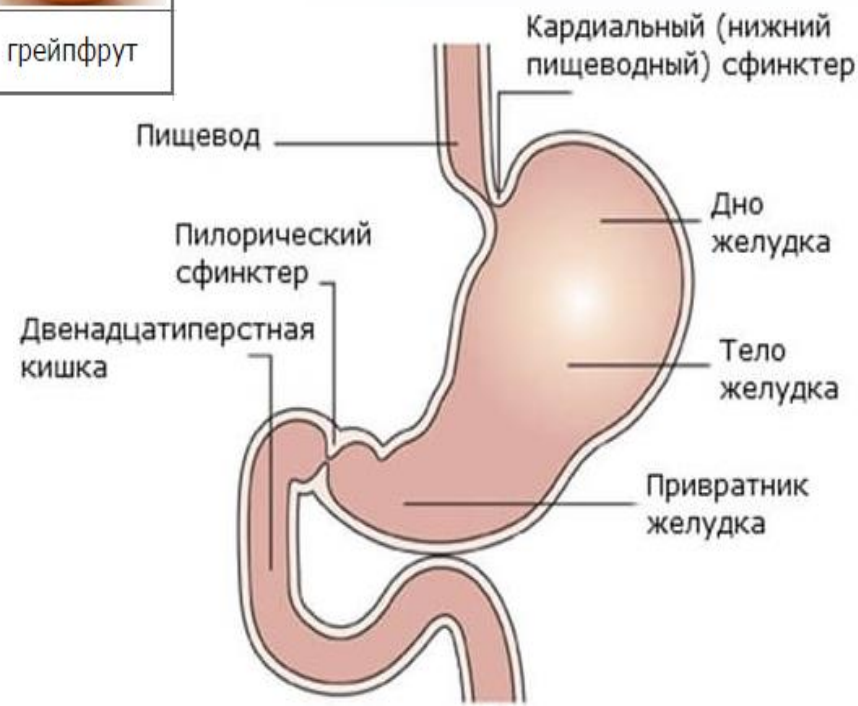
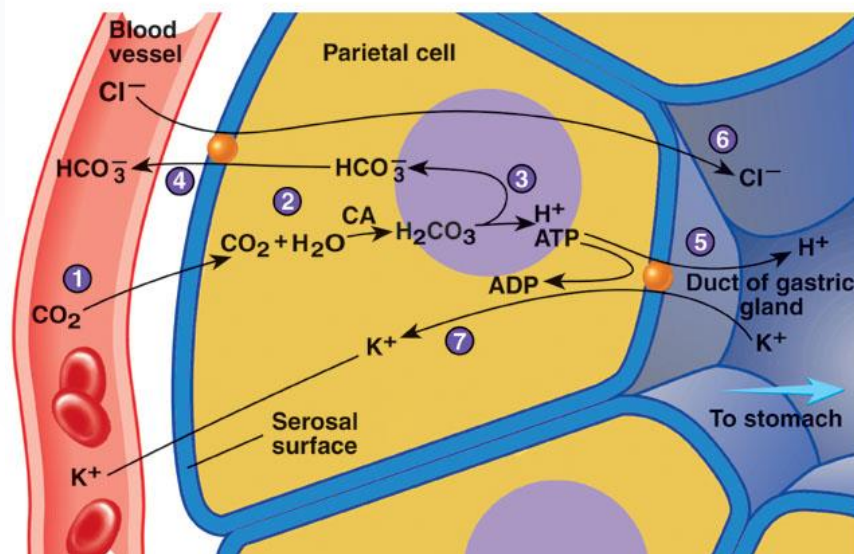


Желудок

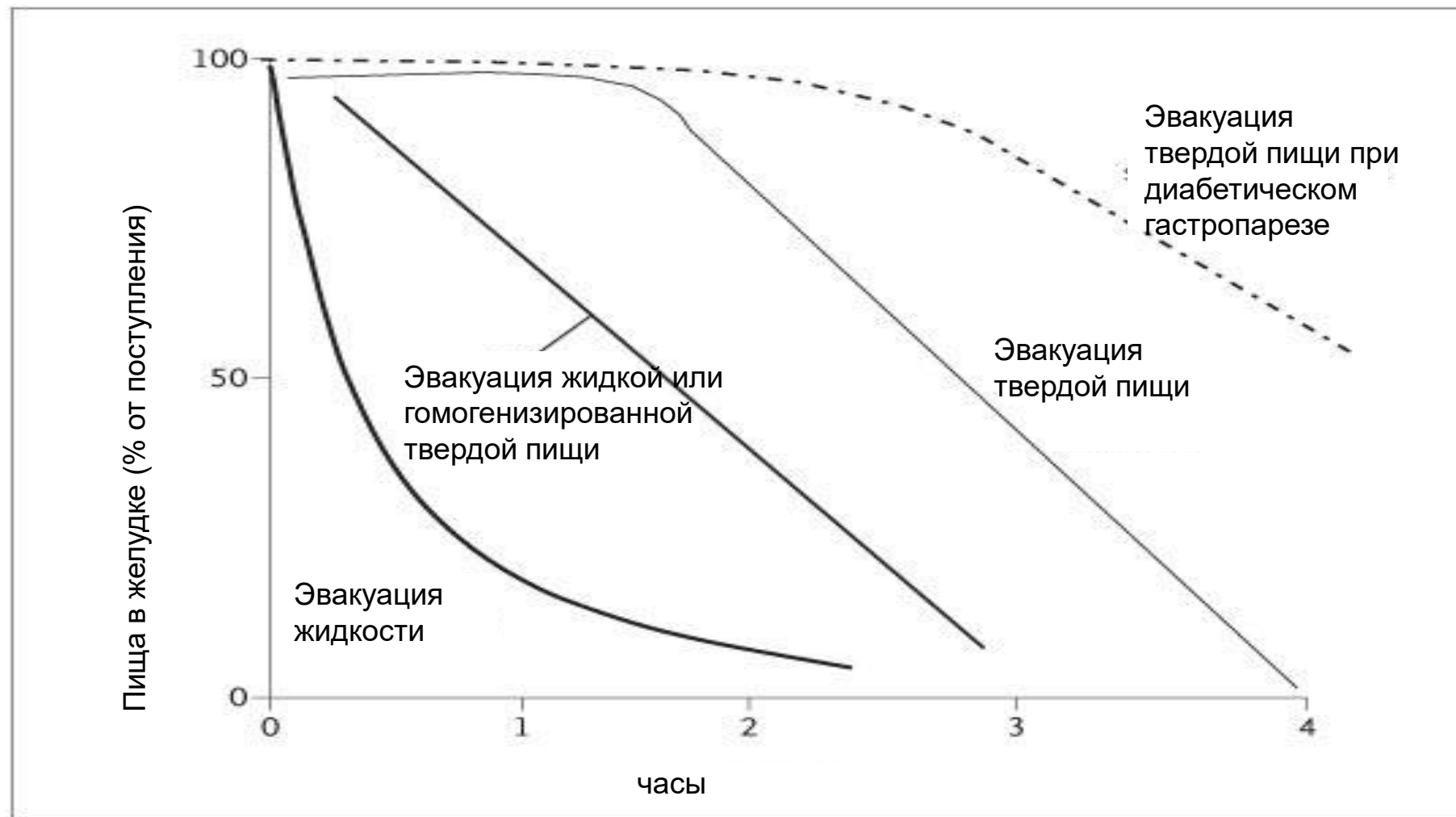


Возраст	1 день	3 - 7 дн.	1 нед. - 10 дн.	1 месяц	Взрослый
Объем желудка (мл)	5 - 7	22 - 27	45 - 60	80 - 150	500
Сравним с:					
	ягода крыжовника	грецкий орех	слива	яйцо	грейпфрут

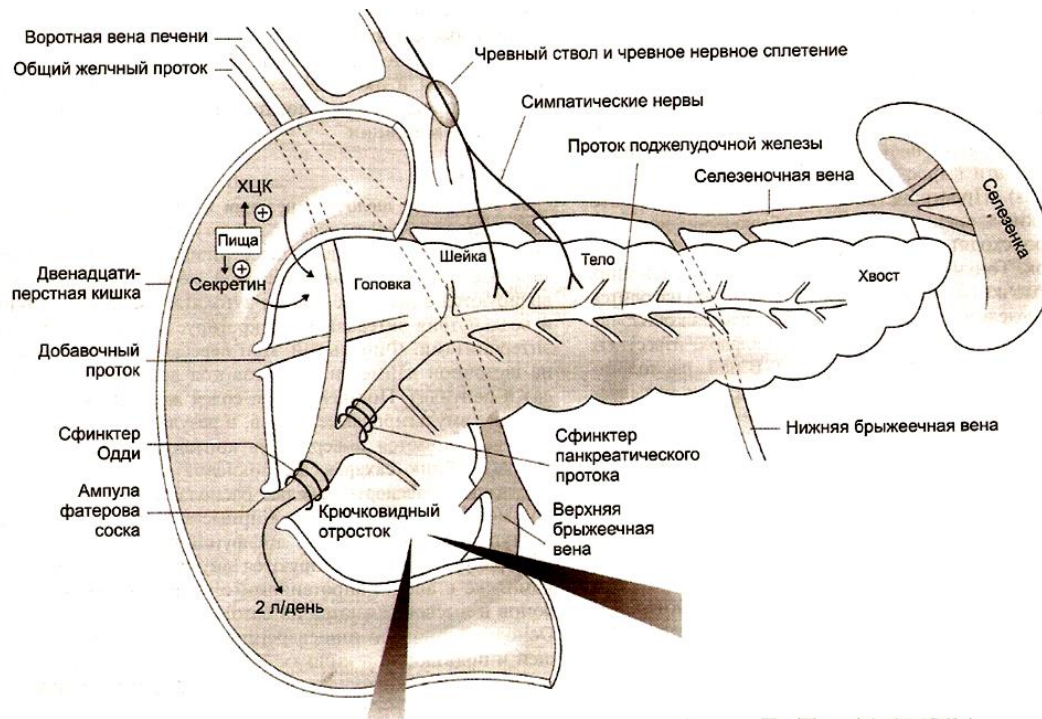
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



Скорость эвакуации пищи из желудка



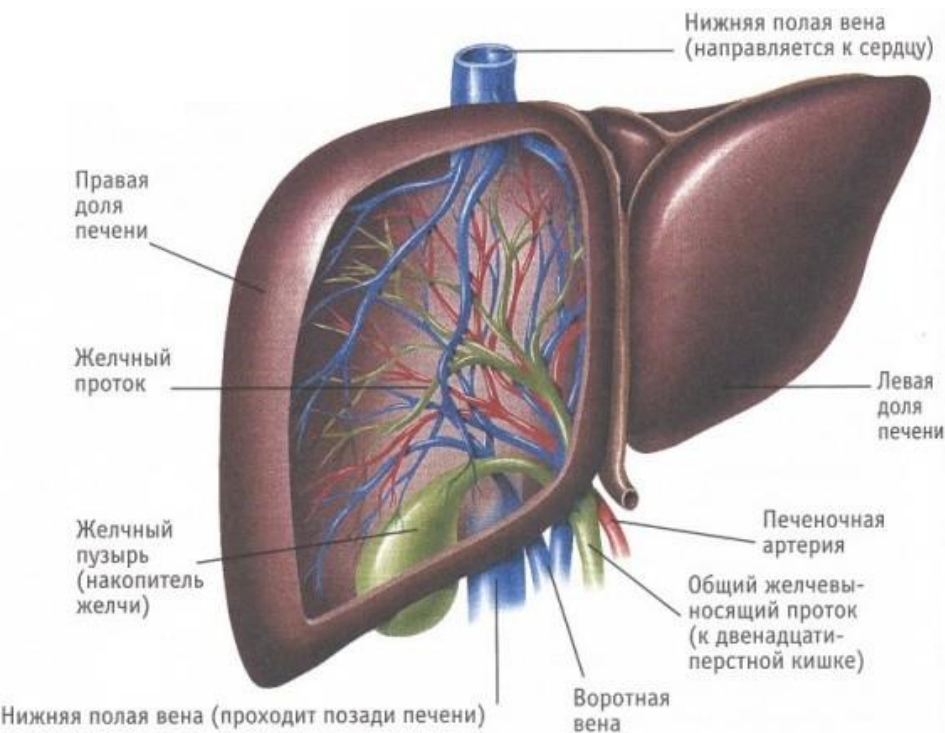
Поджелудочная железа



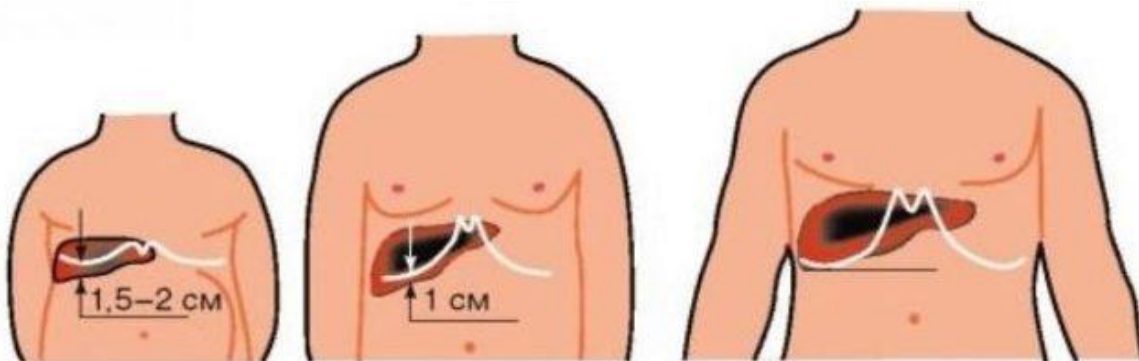
Секрет поджелудочной железы

- ▶ Протеиназы (трипсиноген, химотрипсиноген А, В и С, карбоксипептидазы А и В, проэластаза и зимоген фосфолипазы А
- ▶ Липаза
- ▶ Амилаза
- ▶ Муцин
- ▶ Бикарбонаты, обеспечивающие $\text{pH} = 6,8-8$

Печень



- Биосинтез веществ, функционирующих и используемых в других органах: белки плазмы крови, глюкоза, жиры, кетоновые тела и др.
- Биосинтез мочевины, как конечного продукта обмена азота в организме
- Пищеварительная функция, связанная с синтезом кислот, образованием и секрецией желчи
- Обезвреживание токсических веществ, образующихся в организме и поступающих извне
- Выделение некоторых продуктов метаболизма с желчью в кишечник (избытка холестерина, продуктов распада гема - желчных пигментов и др. метаболитов, образующихся в результате обезвреживания веществ в печени)

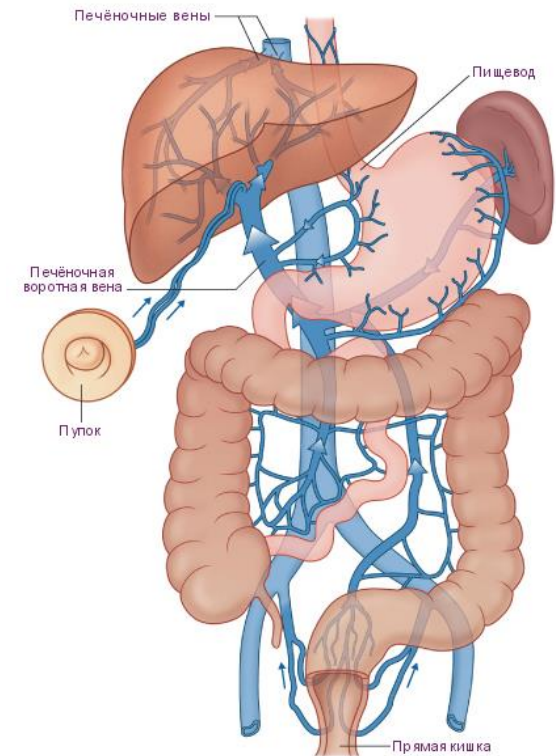


Система портальной (воротной) вены



Воротная вена собирает кровь от нижней трети пищевода, желудка, поджелудочной железы, кишечника и селезенки и несет ее к печени для детоксикации. При заболеваниях печени или самой вены давление в системе портальной вены повышается — развивается **портальная гипертензия**.

При этом вены внутренних органов начинают варикозно расширяться, селезенка увеличивается, а потом начинается отток крови по поверхностным венам передней брюшной стенки и выпот плазмы крови в брюшную полость (асцит)



Симптомы портальной гипертензии



Асцит



Голова Медузы

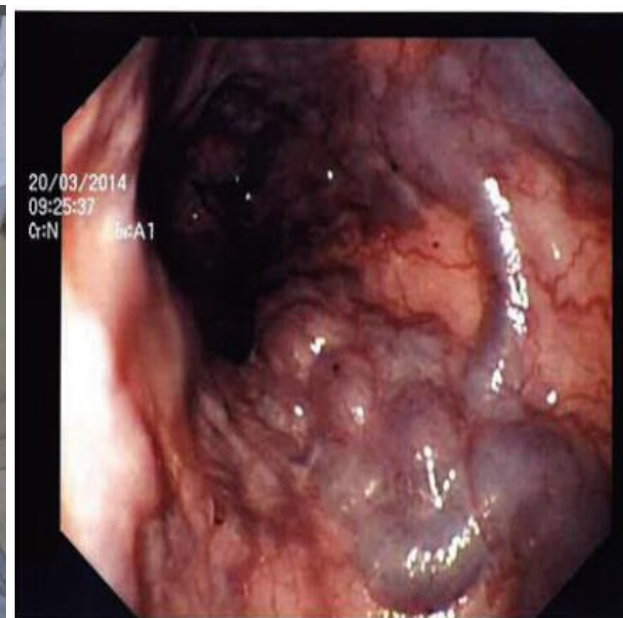
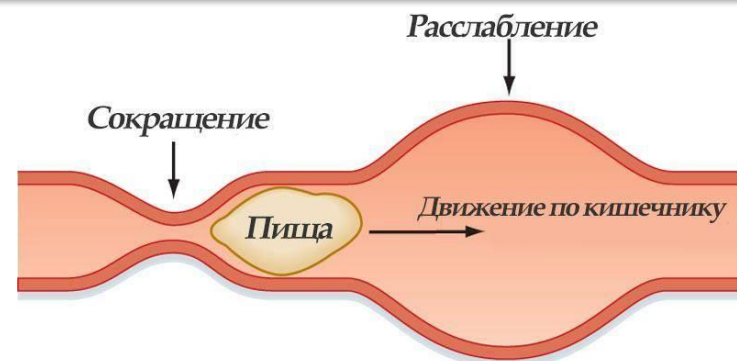
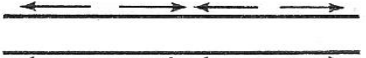


Figure 1 Large esophageal varices at EGD.

ВРВП

Движение пищи



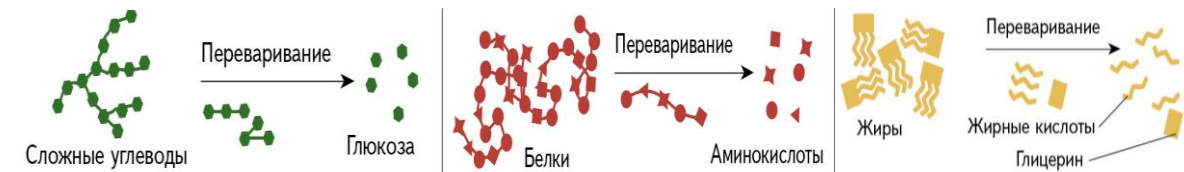
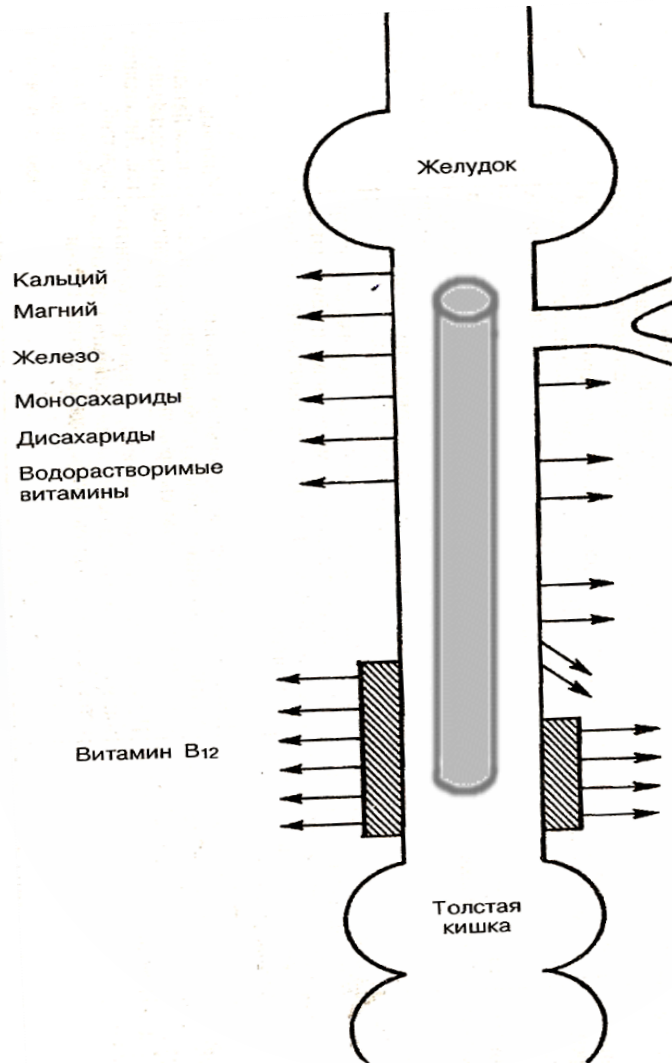
Тип двигательной активности	Структура	Функции
 Перистальтика	Пищевод Желудок Тонкий к-к	Пропульсивная перистальтика — передвижение пищевых масс; непропульсивная перистальтика — перемешивание пищевых масс
 Ритмическая сегментация	Тонкий и толстый кишечник	Перемешивание
 Маятникообразные движения	Тонкий и толстый кишечник	Продольное смещение стенки кишечника относительно химуса
 Тонические сокращения	Сфинктеры пищеварительного тракта	Препятствие передвижению химуса Функциональное разделение отделов

Особенности моторики



- ▶ Моторика кишечника у детей грудного и раннего возраста более активна, чем у старших детей.
- ▶ Это приводит к более частой дефекации.
- ▶ Продолжительность прохождения пищи по кишечнику у детей раннего возраста - 4-18 ч, а у старших детей - более 1 сут.
- ▶ Частота дефекации:
 - ▶ В первые месяцы жизни дефекация обычно происходит практически после каждого кормления 5-7 раз в сутки
 - ▶ 1-3 года - 2-3 раза в сутки
 - ▶ дошкольники - 1-2 раза в сутки
 - ▶ школьники – 1 р/сутки (до 3 р/сутки или 1 р/32-48 часов)

Тонкая кишка

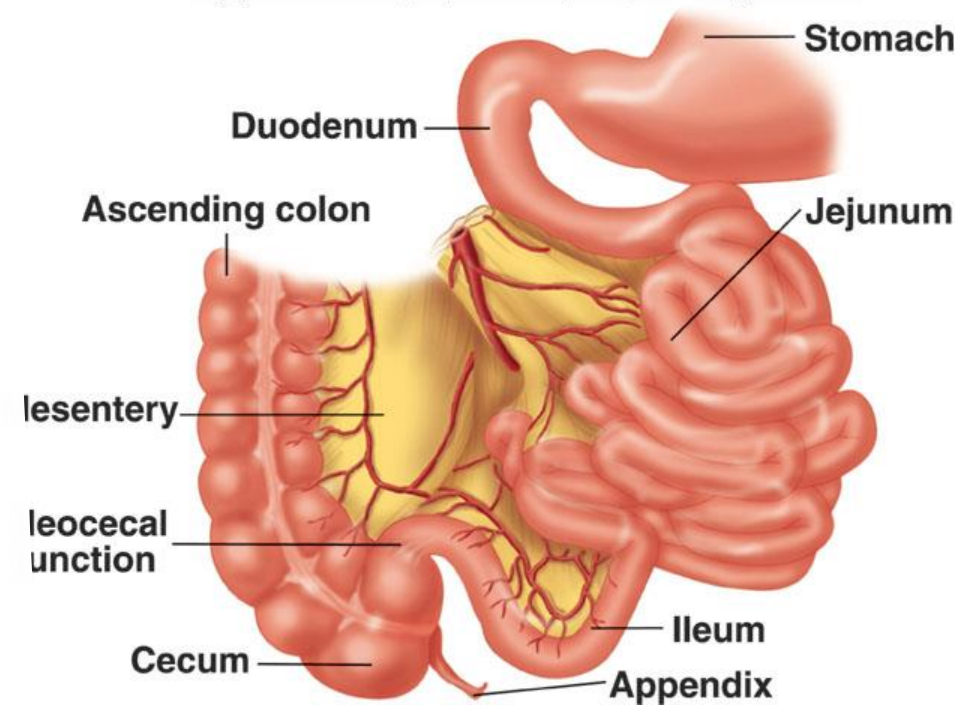


Желчь
Панкреатические ферменты
Жирорастворимые кислоты
Белок
Аминокислоты

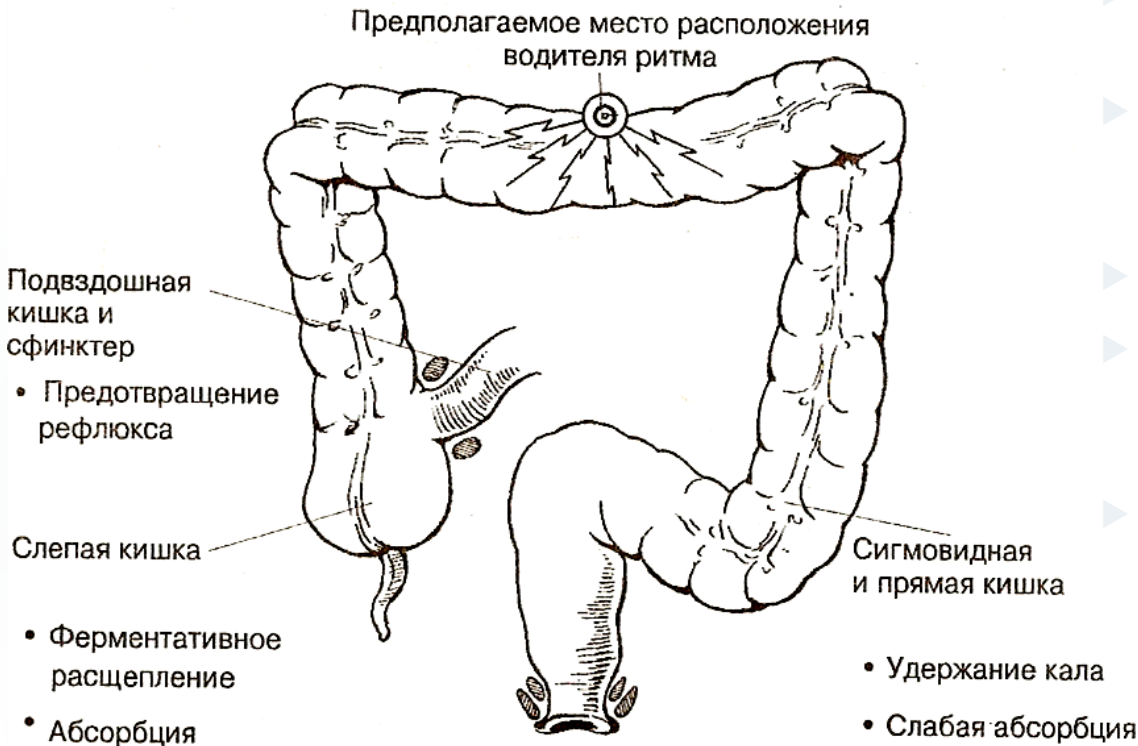
Жир
Жирные кислоты

Желчные кислоты

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



Толстая кишка

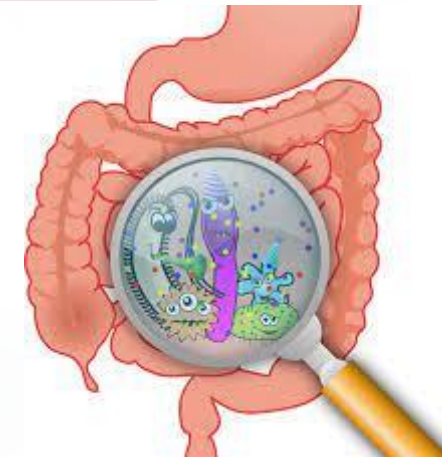


- ▶ Моторная функция у детей раннего возраста неустойчива
- ▶ Эвакуаторно-резервуарная снижена (дети раннего возраста не контролируют акт дефекации)
- ▶ Резорбция воды
- ▶ Пищеварительная (нормальная микрофлора принимает участие в пищеварении, ферментируя лактозу)
- ▶ Другие функции кишечной микрофлоры (иммунологическая, защитная, трофическая, синтез витаминов, участие в циркуляции желчных кислот, инаktivация физиологически активных веществ и ферментов).

Состав микрофлоры кишечника



Микроорганизмы	Дети до 1 года	Дети после 1 года и взрослые	Пожилые
Бифидобактерии	$10^{10}-10^{11}$	10^9-10^{10}	10^9-10^{10}
Лактобактерии	10^6-10^7	10^6-10^7	10^6-10^7
Бактероиды	10^7-10^8	10^9-10^{10}	$10^{10}-10^{11}$
Молочнокислый стрептококк	10^7-10^8	10^6-10^7	10^6-10^7
Энтерококки	10^5-10^7	10^5-10^7	10^5-10^7
Фузобактерии	$<10^6$	10^8-10^9	10^8-10^9
Эубактерии	10^6-10^7	10^9-10^{10}	10^9-10^{10}
Пептострептококки	$<10^5$	10^9-10^{10}	$<10^{10}$
Клостридии	$<10^5$	$<10^5$	$<10^5$
E coli типичные	10^7-10^8	10^7-10^8	10^7-10^8
E coli лактозонегативные	$<10^5$	$<10^5$	$<10^5$
E coli гемолитические	$<10^4$	$<10^4$	$<10^4$
Др. УП энтеробактерии	$<10^4$	$<10^4$	$<10^4$
Грибы рода Candida	$<10^3$	10^4-10^6	10^4-10^6
Стафилококки сапрофитный, эпидермальный	$<10^5$	$<10^5$	$<10^4$



* Согласно Отраслевому стандарту (2003)

Дефекация



- ▶ Фекальные массы, поступающие в прямую кишку, удаляются из нее при акте дефекации, во время которого:
 - гладкие мышцы дистального отдела толстого кишечника прямой кишки сокращаются, проталкивая фекалии в анальный канал;
 - расслабляется внутренний и наружный анальный сфинктер;
 - диафрагма и мышцы брюшного пресса сокращаются, тем самым увеличивая внутрибрюшное давление, что также способствует продвижению фекальных масс через анальный канал.
- ▶ В процессе дефекации принимают участие как произвольные мышцы, так и непроизвольные. После того, как фекальные массы растягивают ректум, активируется ректосфинктерный рефлекс, который приводит к расслаблению внутреннего анального сфинктера, сокращению наружного сфинктера и начинает генерироваться напряжение стенки кишки, необходимое для акта дефекации.
- ▶ Если дефекация не произошла, то внутренний анальный сфинктер закрывается, а толстая кишка расслабляется, тем самым приспособляясь к накопившимся в ней каловым массам.

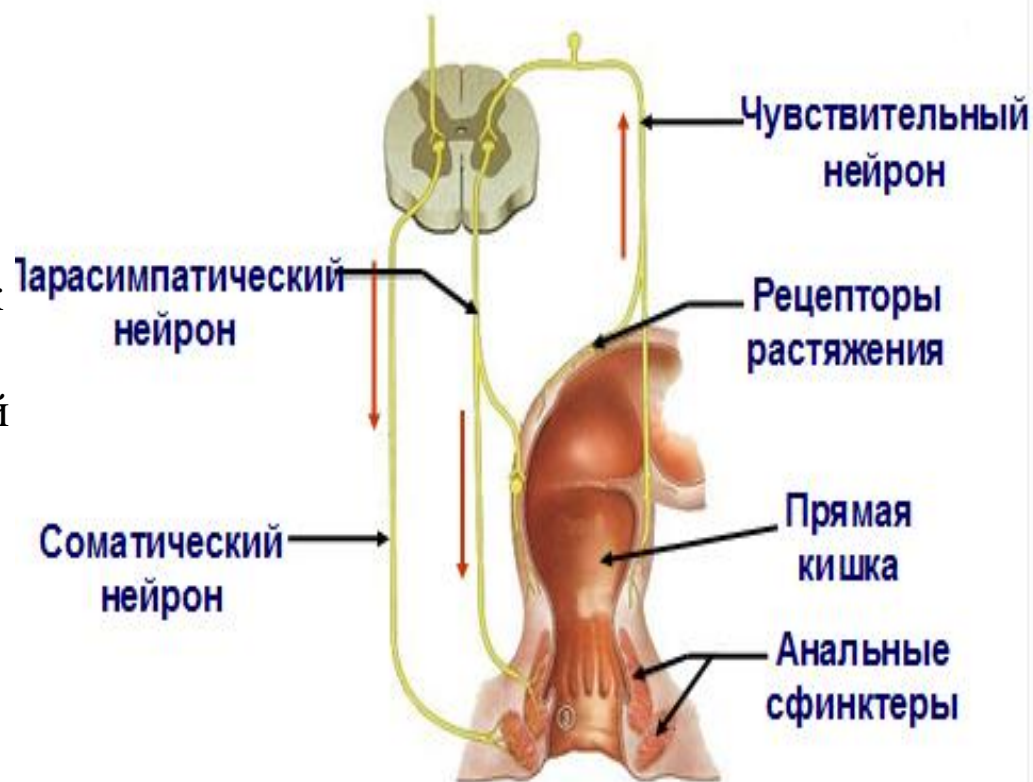


Дефекация в норме



Когда фекалии попадают в прямую кишку, происходит растяжение ее стенки, что приводит к появлению афферентных сигналов. Распространяясь по межмышечному сплетению, они вызывают перистальтические волны в нисходящей, сигмовидной и прямой кишках. В результате происходит продвижение фекалий по направлению к анусу. Как только перистальтическая волна приближается к анусу, внутренний анальный сфинктер расслабляется под действием подавляющих сигналов из межмышечного сплетения; если в это время наружный анальный сфинктер сознательно свободно расслабляется, то происходит дефекация.

Рефлекс дефекации



Частота стула



- ▶ первые месяцы жизни – до 7 раз в сутки
- ▶ первых лет жизни – 2-3 раза в сутки
- ▶ дошкольники – 1-2 раза в сутки
- ▶ школьники – интервал между дефекациями 32-48 часов

- ▶ **ЗАПОР (constipation)** – нарушение самостоятельного опорожнения кишечника (замедленное, затрудненное, недостаточное).
- ▶ **Римские критерии II 1998 г. Запор – 2 признака и > из 4:**
 - выраженное натуживание при дефекации
 - ощущение неполного опорожнения кишечника
 - выделение твердого и сухого кала
 - число дефекаций менее 3-х в неделю

Возрастные особенности кала у детей



Возраст	Название	Внешние особенности		
		Цвет	Консистенция	Запах
1-3 день	Меконий	Темно-зеленый	Густой, гомогенный	Отсутствует
3-5 день	Переходной	Участки разного цвета - белого, желтого, зеленого	Жидкий, водянистый, с комочками слизи	Постепенно становится кислым
С 5-6 дня до 6 мес.	Обычный Естественное вскармливание	Золотисто-желтый	Вид жидкой сметаны	Кислый
	Искусственное вскармливание	Светло-желтый	Кашицеобразный	Гнилостный, резкий
После 6 мес.	Обычный	Коричневый	Плотный	Обычный (естественный, природный)

Возрастные изменения пищеварительной системы



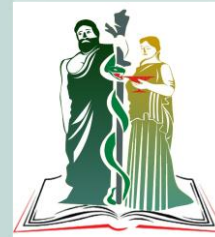
Возрастные изменения при старении

Ротовая полость	Объем ротовой полости уменьшается. Атрофия верхней челюсти опережает атрофию нижней челюсти. Происходит нарушение прикуса, затруднение жевания пищи. Атрофируется мимическая и жевательная мускулатура. Уменьшается объем слюнных желез, снижается ферментативная активность слюны и вкусовая чувствительность (особенно на сладкое, кислое и горькое). Возникает сухость во рту. Появляются трещины языка и губ. Стертость зубов
Пищевод и желудок	Пищевод удлиняется и искривляется, затрудняется прохождение пищи. Снижается тонус мускулатуры нижнепищеводного сфинктера (увеличивается риск возникновения рефлюкс-эзофагита). Снижается секреторная (в том числе кислотообразующая) и моторная функция желудка
Поджелудочная железа	Уже после 40 лет происходит атрофические изменения в железе, что ведет к нарушению внешней и внутренней секреции. Уменьшается число рецепторов к инсулину

Возрастные изменения пищеварительной системы



	Возрастные изменения при старении
Желчный пузырь	Увеличивается в объеме, снижается тонус мышечной стенки. Увеличивается риск развития дискинезии желчевыводящих путей, застоя желчи, что приводит к желчнокаменной болезни.
Печень	Уменьшается масса печени. Увеличивается вероятность нарушений белкового, липидного, углеводного и пигментного обменов в следствие снижения функции гепатоцитов. Снижается антитоксическая функция печени.
Кишечник	Общая длина увеличивается (чаще за счет толстой кишки). В стенке тонкой кишки выявляются атрофические изменения. Возникают нарушения процессов всасывания белков, жиров и углеводов, а также железа, витаминов, кальция. Изменяется микрофлора кишечника: уменьшается число молочнокислых бактерий, увеличивается количество бактерий гнилостной группы, растет продукция эндотоксинов. Нарушается моторная функция кишечника, развивается «старческий запор»

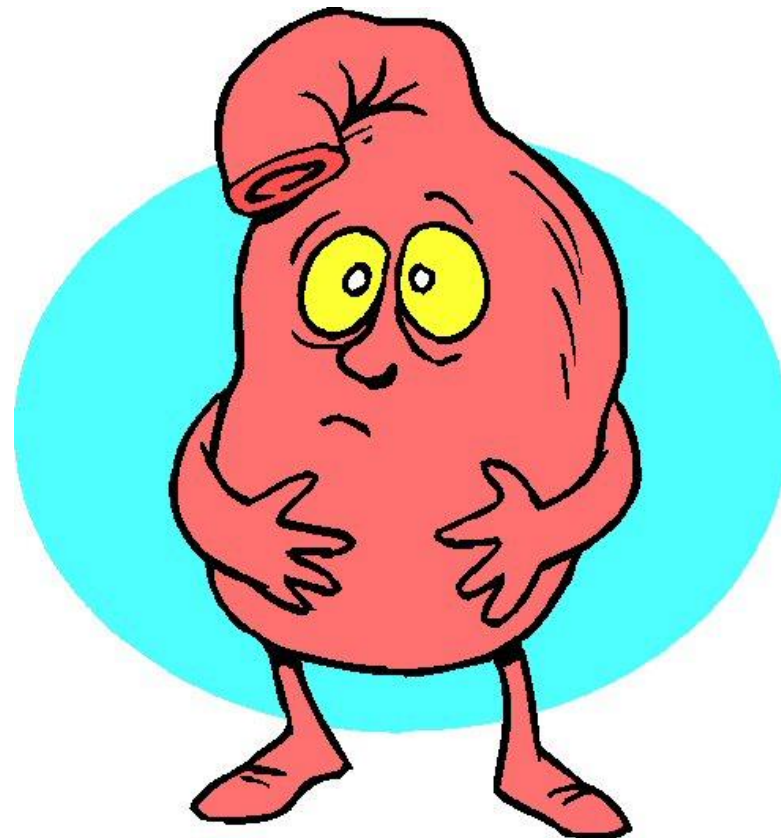


Основные жалобы, симптомы поражения ЖКТ, сестринский уход

Диспепсический синдром



- ▶ Отрыжка
- ▶ Изжога
- ▶ Тошнота
- ▶ Рвота
- ▶ Метеоризм
- ▶ Изменение аппетита
- ▶ Расстройства стула

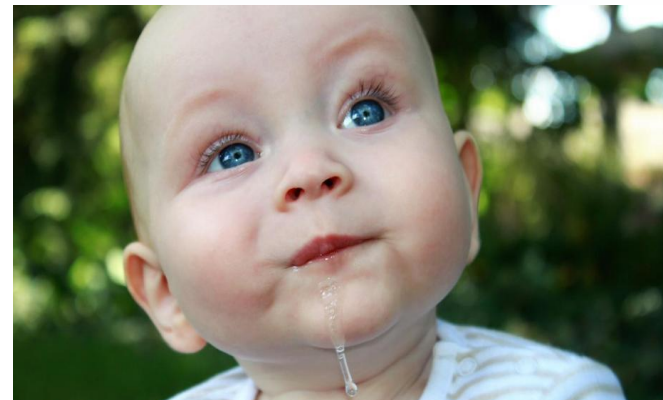


Причины гиперсаливации

Слюнотечение – ptyalism



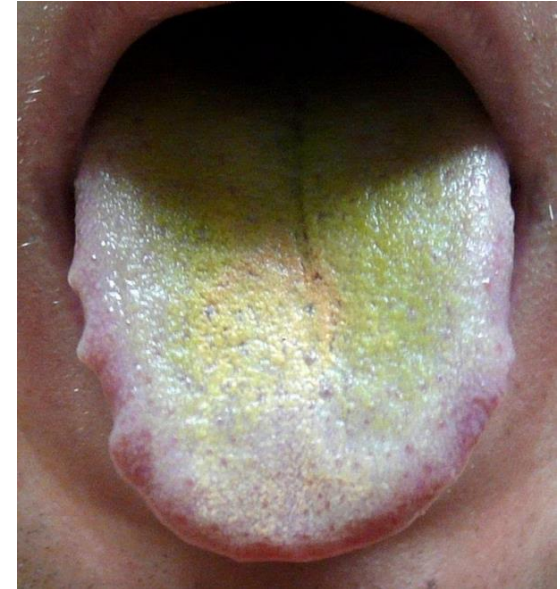
- ▶ Прорезывание зубов
- ▶ Беременность
- ▶ Стоматит
- ▶ Невралгия тройничного нерва,
- ▶ Одонтогенные воспалительные заболевания
- ▶ Период адаптации к съемным пластмассовым протезам
- ▶ Токсические стоматиты (металлические протезы)
- ▶ Паркинсонизм
- ▶ Эпилепсия
- ▶ Опухоли головного мозга
- ▶ ОНМК
- ▶ Гельминтозы
- ▶ Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки
- ▶ Отравления и интоксикации
- ▶ Лекарственные препараты (морфин, пилокарпин, физостигмин, кокаин, препараты ртути)



Последствия гиперсаливации



- ▶ Нарушение речи
- ▶ Нарушение минерализации зубов (уменьшение концентрации кальция, фосфатов)
- ▶ Нарушение пищеварения в желудке (разбавление желудочного сока)
- ▶ Аспирация слюны
- ▶ Мацерация кожи у углов рта – хейлит



Уход при гиперсаливации (слюнотечение – сialорея, пtiализм)

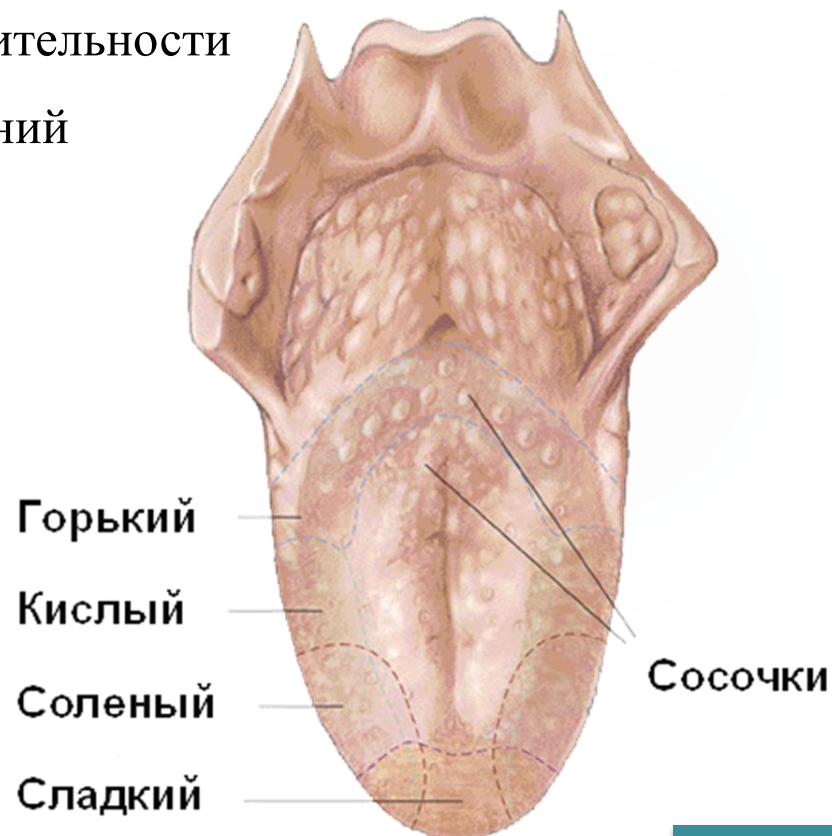
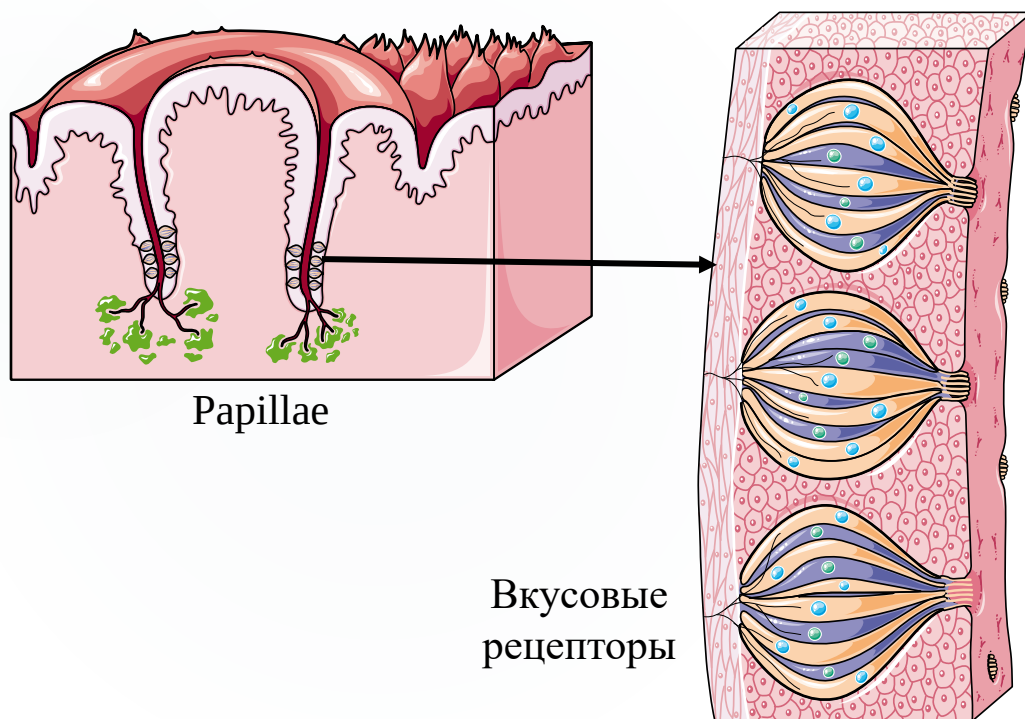


- ▶ При ночной сialорее больным советуют спать на боку, чтобы слюна не попадала в дыхательные пути.
- ▶ Для профилактики мацерации кожи вокруг рта нужно соблюдать гигиену, использовать питательные и увлажняющие кремы (глицерин и др.).
- ▶ Поскольку при обильном слюнотечении есть риск дегидратации, следует увеличить количество выпиваемой за день жидкости.
- ▶ Для уменьшения выработки слюны врачи советуют отказаться от сладостей, газированных напитков и пищи, богатой экстрактивными веществами.
- ▶ Гигиенический уход за ротовой полостью лучше выполнять при помощи слабо пенящихся зубных паст.
- ▶ При нарушениях глотания и дисфункции периоральных мышц назначают моторные упражнения, помогающие контролировать слюнотечение.
- ▶ Лекарственная терапия (М-холинолитики, трициклические антидепрессанты, ботулотоксин).
- ▶ Полоскание рта настоем шалфея, ромашки, ментола.

Нарушение вкуса - дисгевзия



- ▶ Гипогевзия, агевзия – снижение или отсутствие вкусовых ощущений
- ▶ Гипергевзия – повышение вкусовой чувствительности
- ▶ Парагевзия – извращение вкусовых ощущений



Причины гипогевзии



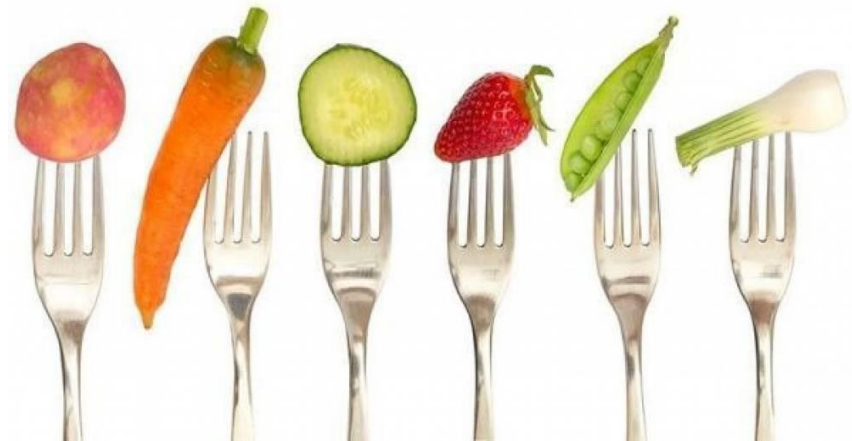
- ▶ Нарушение иннервации и проведения импульсов от вкусовых рецепторов (травма и неврит лицевого нерва, поражение языкоглоточного нерва)
- ▶ Затруднение доступа вкусовых веществ к рецепторам (обложенность языка, лейкоплакия, гипосаливация)
- ▶ Слущивание эпителия слизистой и атрофия сосочков (вирусные инфекции, аллергический глоссит, экссудативная эритема, лучевое и термическое повреждение, авитаминозы А, В)
- ▶ Органические поражения ЦНС (опухоли, нейросифилис) и травмы ЦНС (ЧМТ)
- ▶ Асимболия – отсутствие узнавания вкусовых ощущений – наблюдается при депрессии, шизофрении, ауры эпилептического припадка и др.
- ▶ Действие химических факторов (курение, алкоголь)
- ▶ Съёмное протезирование
- ▶ Инфекционные заболевания (COVID-19, грипп)



Последствия гипогевзии



- ▶ Нарушение секреции желудочного сока
- ▶ Нарушение рефлексорной фазы насыщения, в результате чего может развиваться ожирение
- ▶ Нарушение самочувствия (дискомфорт)
- ▶ Химические ожоги, отравления



- **Специфическое лечение нарушения вкусовой чувствительности отсутствует.**
- **Важную роль придается гигиене рта и поддержанию влажности слизистых оболочек.**
- **Можно добавлять в пищу специи и ароматизаторы.**

Виды нарушения аппетита



- ▶ **Аппетит** (лат. appetitio – сильное стремление, желание) – приятное ощущение, связанное с предстоящим приемом пищи.
- ▶ Снижение аппетита (как правило, обусловлено снижением секреции и кислотности желудка).
- ▶ Полная потеря аппетита – анорексия (греч. Ап – приставка, обозначающая отсутствие признака, orexis – желание есть, аппетит).
- ▶ Повышение аппетита (при язвенной болезни, панкреатите).
- ▶ Булимия (греч. bus – бык, limós – голод) – патологически усиленное чувство голода вплоть до непреодолимой прожорливости.



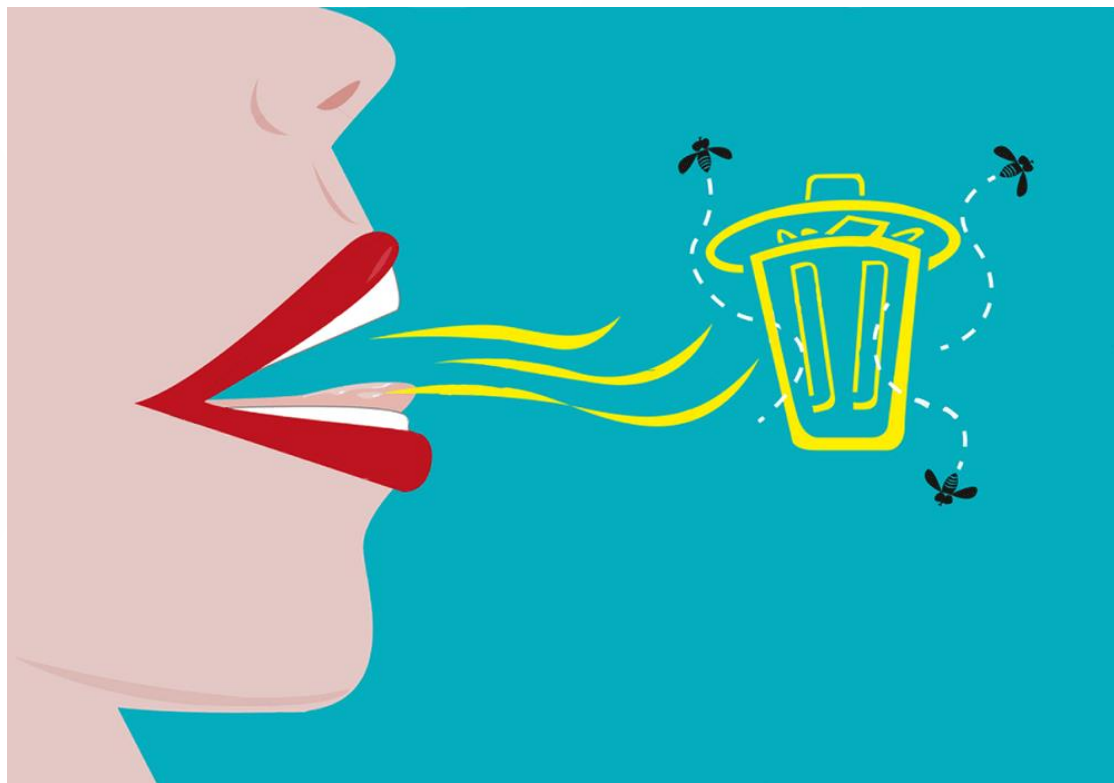
Халитоз



- неприятный запах изо рта, который ощущается в выдыхаемом воздухе (собственно «халитоз») или независимо от акта дыхания

Варианты:

- ▶ бактериальный халитоз;
- ▶ экзогенный халитоз;
- ▶ псевдохалитоз (психогенный);
- ▶ симптоматический халитоз.



Уход при халитозе (галитозе)



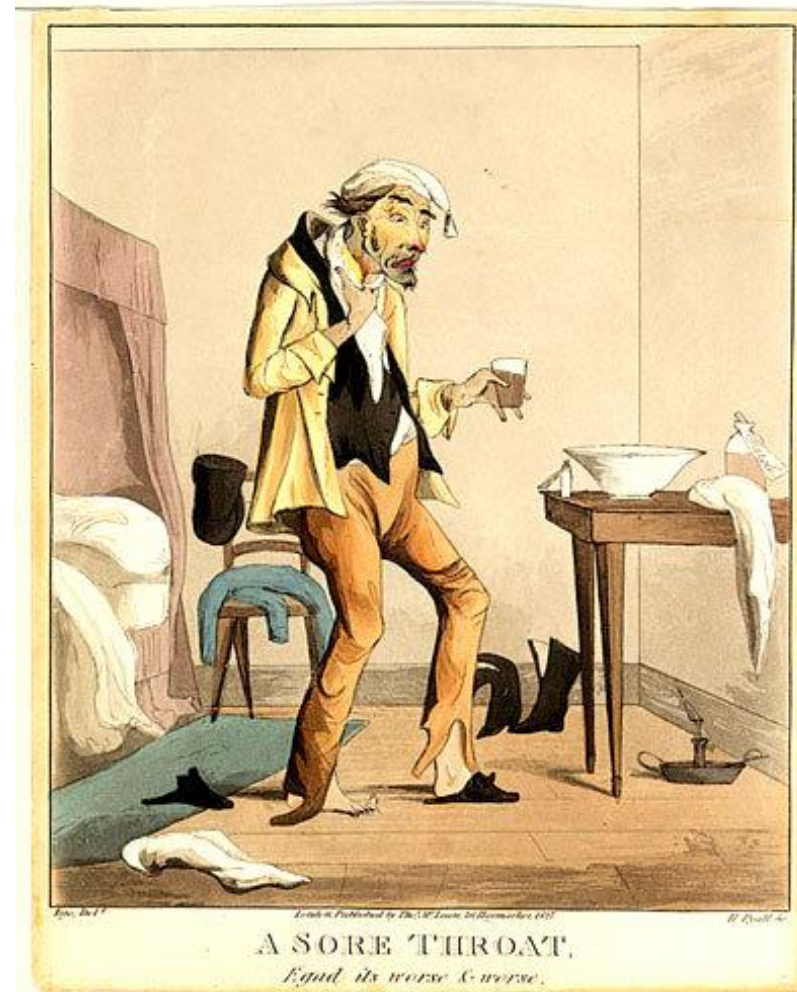
- Тщательный уход за полостью рта, устранение возможных стоматологических заболеваний;
- Тщательная чистка зубов, десен, языка (от налета)
- Устранение этиологических факторов (лечение тонзиллита, ГЭРБ и др.).



Дисфагия



- ▶ **Дисфагия** – это нарушение глотания.
- ▶ **Причины:**
 - Механическое сдавливание глотки или пищевода.
 - Нервно-мышечное расстройство.
 - Эзофагеальные патологии.
- ▶ **Классификация по степени выраженности симптомов:**
 - I степень – затруднено проглатывание твердых кусочков пищи.
 - II степень – пациент может употреблять только жидкую еду.
 - III степень – нарушено глотание пищи и слюны.
 - IV степень – полная непроходимость пищевода.



Н. Pyall (fl. 1833) A Sore Throat

Механические причины нарушения моторики пищевода

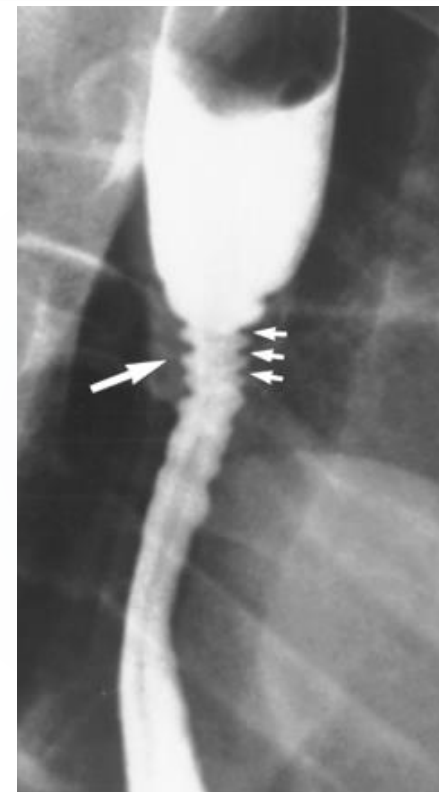
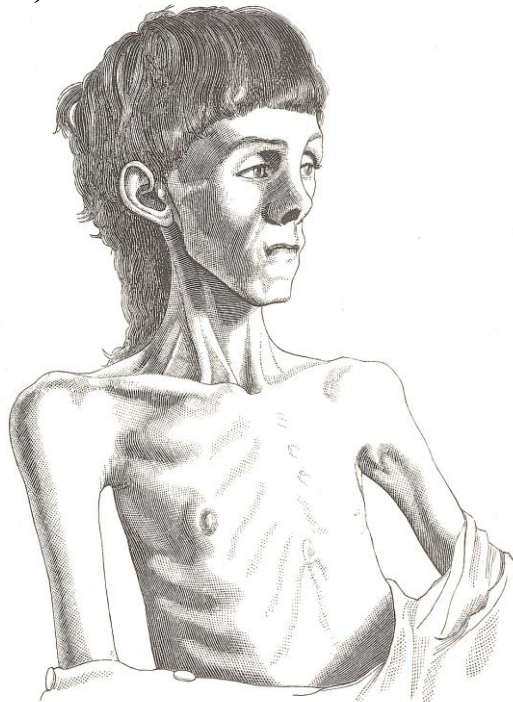


Интраэзофагеальные	Экстраэзофагеальные
•Опухоли пищевода •Стриктуры •Воспаление (кандидоз, Herpes zoster) •Острые и хронические эзофагиты •Спазмы устья пищевода (фарингоэзофагеальная ахалазия)	•Экстраэзофагеальные опухоли •Метастазы в средостение и легкие •Опухоли, кисты диафрагмы •Аномалии аорты, подключичной артерии •Склеротический процесс •Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы •Дивертикулиты

Последствия нарушения глотания



- ▶ Аспирация пищи
- ▶ Рвота
- ▶ Заброс кислоты из желудка (при атонии)
- ▶ Голодание



СТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ СКРИНИНГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ ГЛОТАНИЯ

СКРИНИНГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ГЛОТАНИЯ

Пациент РАЗБУЖЕН и ПОСАЖЕН: Дата: ____/____/____

Прежде, чем проводить тестирование – заполните этот лист (в течение первых 3-х часов с момента поступления пациента в стационар)

Ф.И.О.:.....Отделение.....Палата.....

1. Пациент бодрствует или может быть разбужен? Реагирует на обращение? ДА ☐

НЕТ ☐

2. Может ли пациент быть посажен? Может ли, сидя контролировать положение головы? ДА ☐

НЕТ ☐

Если вы ответили **НЕТ** хотя бы на 1 вопрос – остановитесь и

НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Производите повторные оценки каждые 24 часа. Обсудите вопросы питания и гидратации с врачами.

3. Может ли пациент покашливать, если его попросить об этом? ДА ☐

НЕТ ☐

4. Может ли пациент контролировать слюну: вовремя проглатывать, не допускать истечение слюны изо рта? ДА ☐

НЕТ ☐

5. Может ли пациент облизать губы? ДА ☐

НЕТ ☐

6. Может ли пациент свободно дышать? ДА ☐

НЕТ ☐

Если ответы на 3-6 вопросы «ДА» – переходите к тестированию

Если на любой из вопросов вы ответили «НЕТ» – ОБРАТИТЕСЬ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГЛОТАНИЮ

7. Голос пациента влажный или хриплый? ДА ☐ обратитесь к специалисту по глотанию

НЕТ ☐ приступайте к тестированию

Если сомневаетесь, обсудите со специалистом по глотанию и/или врачом.

Лист заполнил(а):

Дата: «____» _____ 20____

Время: ____ час. ____ мин.

Подпись:..... /Фамилия...../

Дайте первую чайную ложку воды

Все нормально

Дайте вторую чайную ложку воды

Все нормально

Дайте третью чайную ложку воды

Все нормально

Дайте стакан, заполненный на 1/2 водой, попросите сделать несколько глотков

Все нормально

Нет попыток проглотить или вода выплевывается изо рта, возникший кашель, «влажный» хриплый голос, появление одышки

Возникли кашель, удушье или одышка, хриплый «влажный» голос, вы чувствуете что-то неладное

Возникли кашель, удушье или одышка, хриплый «влажный» голос, вы чувствуете что-то неладное

Возникли кашель, удушье или одышка, хриплый «влажный» голос, вы чувствуете что-то неладное

Пациент НЧР (ничего через рот) консультация специалиста по глотанию

Пациент НЧР (ничего через рот) консультация специалиста по глотанию

Пациент НЧР (ничего через рот) консультация специалиста по глотанию

Пациент НЧР (ничего через рот) консультация специалиста по глотанию

Если все нормально – выписывайте соответствующий стол (диету). Убедитесь, что пациент посажен для приема пищи и наблюдайте, как он/она справляется. При любых сомнениях – обратитесь к специалисту по глотанию.

ПОВТОРИТЕ ОЦЕНКУ ПРИ УХУДШЕНИИ СОСТОЯНИЯ

Скрининговое тестирование произвел(а):.....

Сестринская помощь при дисфагии



- ▶ Правильный выбор способа кормления пациента
- ▶ Расчет энергетической ценности и подбор питательных смесей для нутритивной поддержки
- ▶ Гигиенический уход за полостью рта
- ▶ Логопедическая коррекция, направленная на подбор консистенции пищи, способов стимуляции чувствительности слизистых оболочек полости рта, стимуляцию и растормаживание акта глотания, восстановление дыхания, речи – по согласованию с логопедом
- ▶ Лечебная логопедическая гимнастика
- ▶ Психологическая коррекция
- ▶ Бытовая коррекция, направленная создание условий, облегчающих прием пищи пациентом самостоятельно в условиях сниженной или нарушенной функции.

Отрыжка (лат. eructatio)



- ▶ Внезапное непроизвольное, иногда звучное выделение через рот воздуха, скопившегося в желудке или пищеводе – отрыжка воздухом.
- ▶ Может сопровождаться поступлением в рот небольшого количества желудочного содержимого – отрыжка пищей.
- ▶ Отрыжка воздухом наблюдается при аэрофагии.
- ▶ **Аэрофагия** (греч. aeros – воздух, phagein – поглощать) – заглатывание избыточного количества воздуха с последующим его отрыгиванием. Наблюдается при быстром приеме пищи, при ряде заболеваний желудочно-кишечного тракта, при психических расстройствах.



Регургитация у грудных детей



- ▶ Проявление гастроэзофагеального рефлюкса, обусловленного анатомо-физиологическими особенностями верхнего отдела пищеварительного тракта грудного ребенка.
- ▶ Имеет необильный характер.
- ▶ Возникает не позже одного часа после кормления.
- ▶ Не сопровождаются вегетативными симптомами.
- ▶ Не отражаются на самочувствии, поведении.
- ▶ Не страдает аппетит ребенка.
- ▶ Прибавка массы тела стабильная.

Оценка интенсивности срыгиваний в баллах



0 баллов	Отсутствие срыгиваний
1 балл	Менее 5 срыгиваний в сутки объемом не более 3 мл
2 балла	Более 5 срыгиваний в сутки объемом более 3 мл
3 балла	Более 5 срыгиваний в сутки объемом до 1/2 количества смеси, введенной за одно кормление; не чаще, чем в половине кормлений
4 балла	Срыгивания небольшого объема в течение 30 мин. И более после каждого кормления
5 баллов	Срыгивания от 1/2 до полного объема смеси, введенной во время кормления; не менее, чем в половине кормлений

Лечение регургитации у детей раннего возраста



- ▶ Постуральная терапия – терапия положением. У грудных детей она заключается в кормлении ребенка в полувертикальном положении под углом 45-60°, что препятствует аэрофагии и регургитации.
- ▶ Алиментарная коррекция
- ▶ Медикаментозное лечение



На плече



Перед собой

Изжога (лат. pyrosis)



- ▶ Болезненное ощущение жжения за грудиной или в эпигастральной области, нередко распространяющееся вверх до глотки.
- ▶ Обусловлена раздражением слизистой оболочки пищевода вследствие заброса кислого желудочного содержимого в пищевод.
- ▶ Сестринский уход:
- ▶ Применение антацидов (по назначению врача), минеральной воды;
- ▶ Придание возвышенного положения туловища в ночное время (поднятие головного конца кровати);
- ▶ Гигиена полости рта, удаление неприятного вкуса и запаха изо рта (чистить зубы, прополоскать рот отваром мяты, ромашки или кипяченой водой).



Тошнота (лат. nausea)



- ▶ Тягостное ощущение в подложечной области, груди, глотке и полости рта, нередко предшествующее рвоте.
- ▶ Может сопровождаться: слюнотечением, бледностью кожных покровов, слабостью, повышенным потоотделением, головокружением, снижением артериального давления, иногда полуобморочным состоянием.
- ▶ В основе тошноты – возбуждение рвотного центра.



Рвота (лат. emesis)



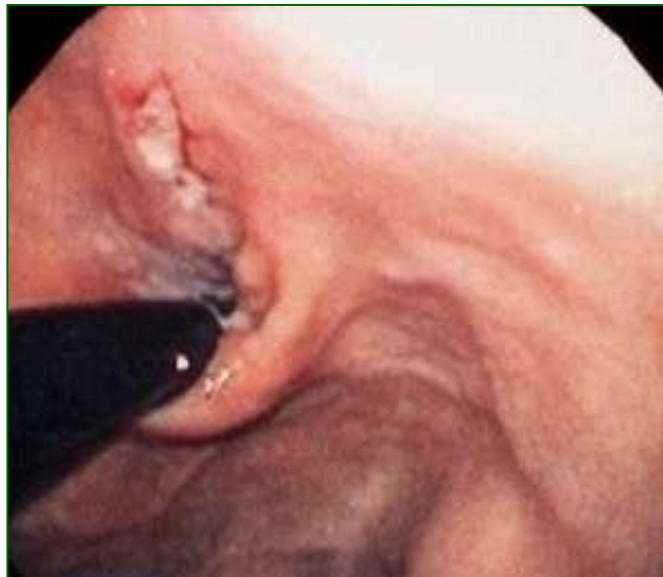
- ▶ Сложный рефлекторный акт, непроизвольное извержение содержимого желудка через рот (реже и через нос).
- ▶ Непосредственная причина – раздражение рвотного центра (в дне IV желудочка)
- ▶ **Желудочная:** обычно обильная, возникает на высоте пищеварения (через 0,5-1,5 ч после еды), предшествует тошнота, облегчение после рвоты.
- ▶ **Рефлекторная:** необильная, чаще – внезапно, без предшествующей тошноты, не приносит облегчения.
- ▶ **Центрального генеза:** на высоте церебральных расстройств (головные боли, головокружение, повышение АД), чаще – без предшествующей тошноты, не приносит облегчения.



Последствия рвоты



- ▶ Нарушение питания (потеря веса, нарушение развития) Кожные (петехии на шее и лице) – повышение внутригрудного давления
- ▶ Повреждения зубов, глотки
- ▶ Эзофагит, эзофагальная гематома, синдром Мэллори-Вейса
- ▶ Метаболические



Характер рвотных масс при заболеваниях ЖКТ



ВНЕШНИЙ ОСМОТР	ПАТОЛОГИЯ
кислый запах, прозрачный желудочный сок, кусочки недавно съеденной пищи	рвота свежесъеденной пищей (отравления)
тухлый запах, пища съеденная один-два дня назад	рвота застойная (давно съеденной пищей)
рвотные массы желто-зеленого цвета (с примесью желчи)	желчная
с запахом кала, коричневатого цвета	каловая
с кровью, «кофейная гуща»	кровавая

Характеристика рвотных масс и пример патологии



ВНЕШНИЙ ОСМОТР	ПАТОЛОГИЯ
кислый запах, прозрачный желудочный сок, кусочки недавно съеденной пищи	острый гастрит (неинфекционный/инфекционный – ПТИ)
тухлый запах, пища съеденная один-два дня назад	стеноз пищевода (рак пищевода) или желудка (рубцовый стеноз на фоне ЯБЖ, рака желудка)
рвотные массы желто-зеленого цвета (с примесью желчи)	Холецистит, при многократной рвоте – независимо от заболевания
с запахом кала, коричневатого цвета	ОКН
алая кровь	кровотечение из пищевода, интенсивное кровотечение из желудка

Сестринская помощь при рвоте (пациент в сознании)



- Успокоить, оказать психологическую поддержку;
- Объяснить пациенту правила поведения во время рвоты;
- Подготовить оснащение: клеенку, фартук, салфетку, таз, ведро, воду для полоскания рта, лоток;
- Усадить, если пациент контролирует свои действия;
- Успокоить пациента, надеть на него фартук или положить на грудь салфетку, поставить к ногам таз;
- При рвоте поддержать голову пациента, положив ему на лоб ладонь;
- После рвоты дать пациенту воду для полоскания рта, помочь умыться лицо, вымыть руки, вытереть его полотенцем, помочь лечь;
- Унести таз, при необходимости – показать врачу рвотные массы;
- По назначению врача – ввести противорвотные препараты.



Сестринская помощь при рвоте (пациент без сознания)



▶ Зафиксировать положение пациента на боку при помощи подушек, если невозможно изменить положение – надо повернуть на бок голову во избежание аспирации рвотных масс;

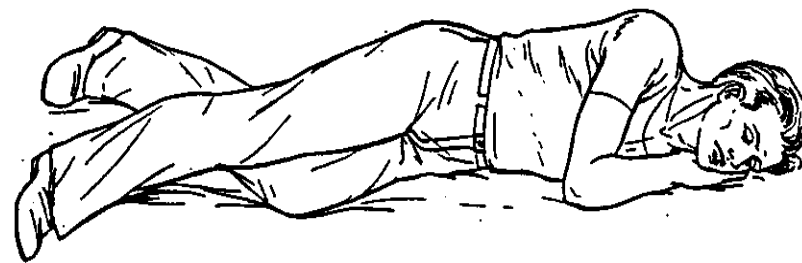
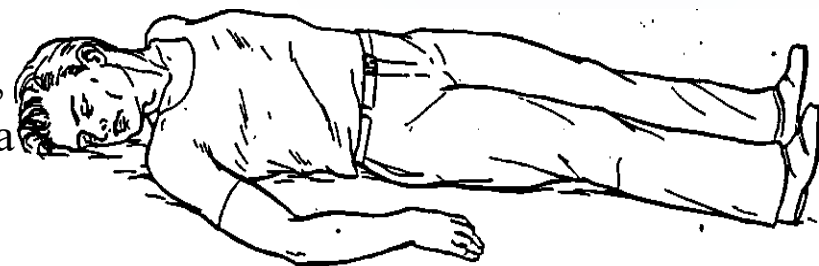
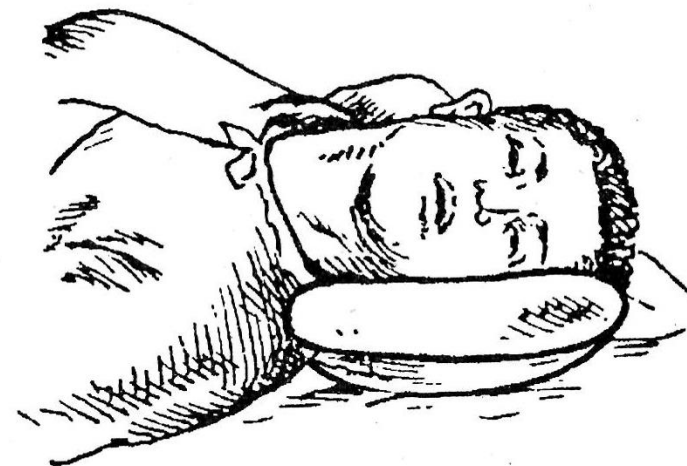
▶ Шею и грудь пациента прикрыть салфеткой или клеенкой;

▶ Подставить ко рту пациента почкообразный лоток;

▶ По окончании рвоты, обработать полость рта водой или 2% раствором гидрокарбоната натрия, при необходимости, аспиратором из полости рта удалить рвотные массы;

▶ Унести лоток, при необходимости, показать врачу рвотные массы;

▶ При необходимости – установить назогастральный зонд!



Рвота «кофейной гущей»



- ▶ Связанная кровь с HCl и образование солянокислого гематина

Помощь:

- ▶ вызвать врача;
- ▶ оказать психологическую поддержку;
- ▶ обеспечить лотком для сбора рвотных масс;
- ▶ положить пузырь со льдом на эпигастральную область;
- ▶ оценить функциональное состояние пациента (измерить АД, пульс, подсчитать ЧДД);
- ▶ приготовить необходимые гемостатические лекарственные средства;
- ▶ по назначению врача – установить зонд, промыть желудок;
- ▶ подготовить пациента к лабораторным и эндоскопическим исследованиям.

Размеры зонда



Возраст ребенка	Диаметр зонда, мм	Глубина введения зонда, см
Новорожденный	3	20
До 3 мес	4	25
До 1 года	6	28
2 – 5 лет	10	30
Более 5 лет	12	35
9 – 14 лет	14 – 16	40 – 50
Старше 15 лет	16 – 20	50

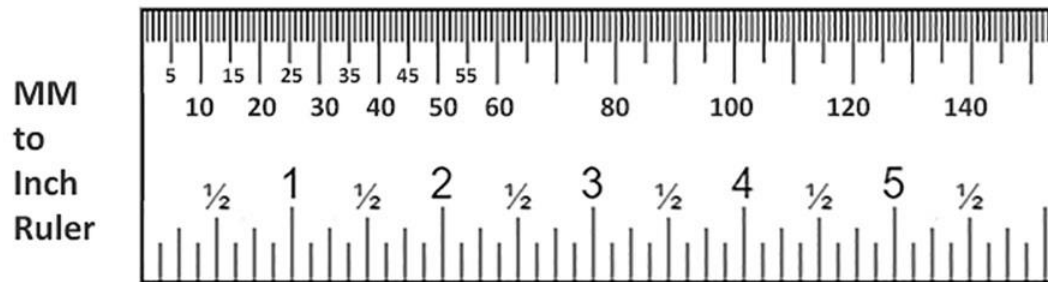
Размеры зондов



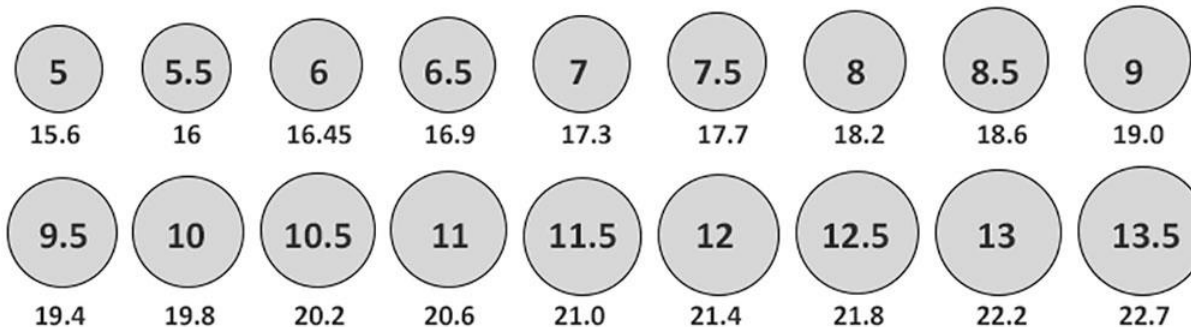
Ch/Fr	I.D. (мм)	O.D. (мм)	Цвет
6	1,1	2,0	бордовый
8	1,7	2,7	голубой
10	2,3	3,3	черный
12	2,8	4,0	белый
14	3,3	4,7	зеленый
16	3,8	5,3	оранжевый
18	4,5	6,0	красный
20	5,1	6,7	желтый
22	5,6	7,3	синий
24	6,2	8,0	фиолетовый
26	6,9	8,7	зеленый
28	7,5	9,3	темно-зеленый
30	8,0	10,0	серый
32	8,7	10,7	коричневый



Size Comparisons



US Ring Sizes - MM in Diameter



$$D \text{ (mm)} = Fr / 3$$



Жозеф Фредерик
Бенуа Шаррьер
(1803 – 1876)

Отличия зондов



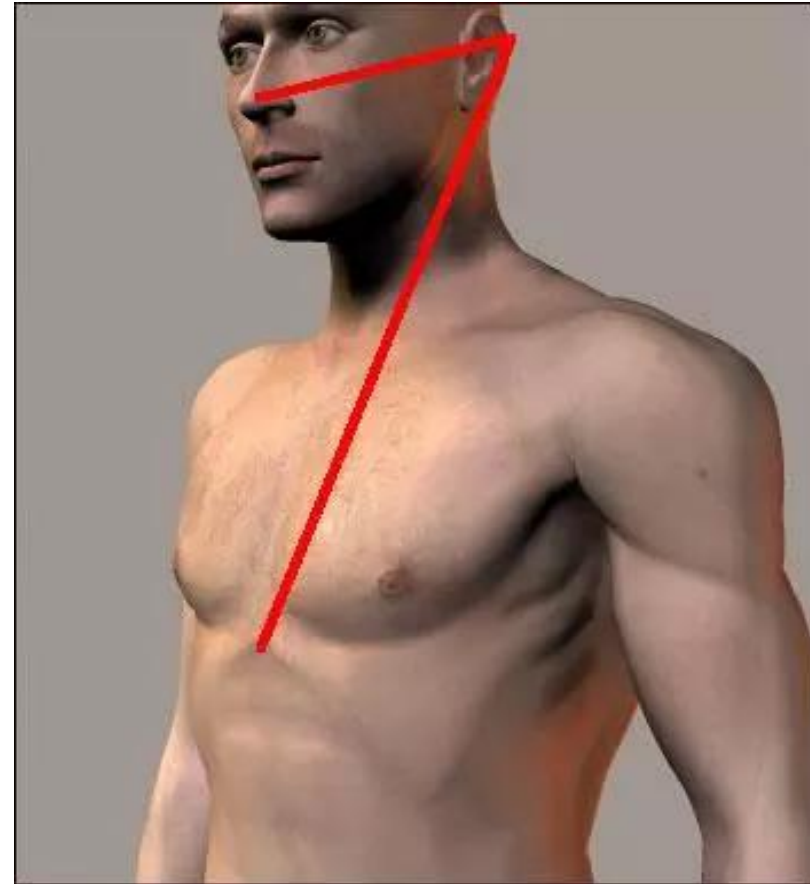
Вид зонда	Характеристика	Предназначение
Тонкий желудочный	Диаметр 5-9 мм	Фракционное исследование желудочного содержимого, питание больного
Толстый желудочный	Диаметр 10-15 мм, длина 100-120 см; для определения глубины погружения имеются три метки - на 45, 55 и 65 см	Одномоментное извлечение содержимого желудка при исследовании желудочного сока, промывание желудка
Желудочный двухтрубчатый	Состоит из двух резиновых трубок и баллончика на конце одной из трубок	Забор содержимого желудка при механическом раздражении стенок желудка баллончиком, в который накачивают воздух
Гастродуоденальный двойной	Зонд с двумя каналами	Одновременное извлечение содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки
Дуоденальный	Диаметр 4,5-5 мм, длина 140-150 см, на конце металлическая олива с прорезями; для определения глубины погружения имеется девять меток на расстоянии по 10 см каждая	Введение в двенадцатиперстную кишку для дуоденального зондирования



Алгоритм постановки назогастрального зонда



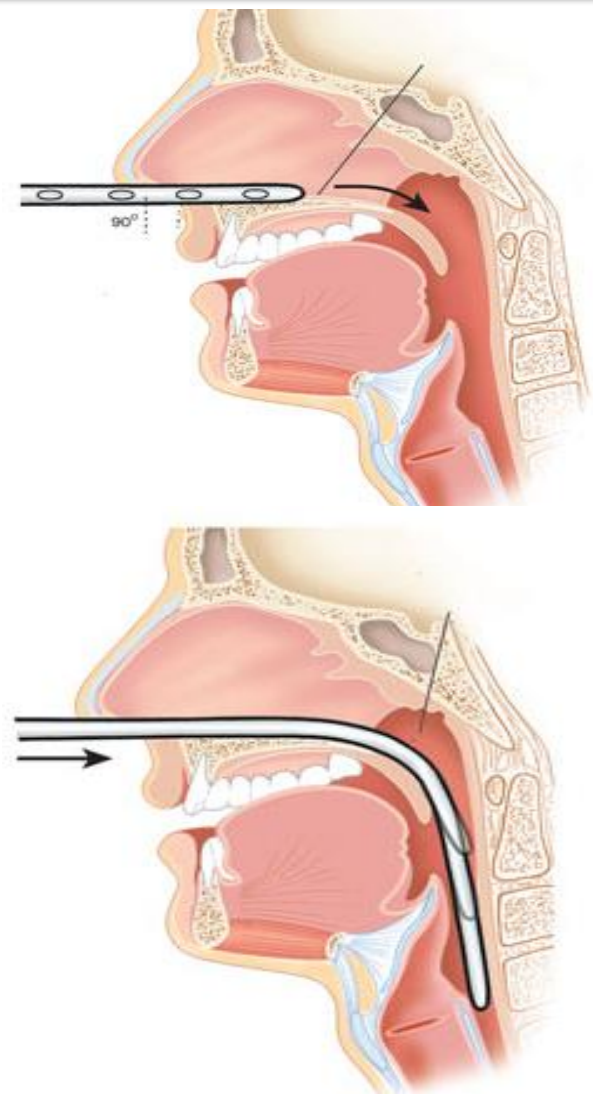
- ▶ Оснащение
1. Стерильный желудочный зонд диаметром 0,5 – 0,8 см.
 2. Глицерин или вазелиновое масло.
 3. стакан с водой 30 – 50 мл и трубочка для питья.
 4. Шприц Жане или шприц объемом 20,0.
 5. Лейкопластырь.
 6. Зажим.
 7. Ножницы.
 8. Заглушка для зонда.
 9. Безопасная булавка.
 10. Лоток.
 11. Полотенце.
 12. Салфетки
 13. Перчатки.
 14. Фонендоскоп.
 15. 3–4 стакана питательной смеси и стакан теплой кипяченой воды.



Подготовка к процедуре

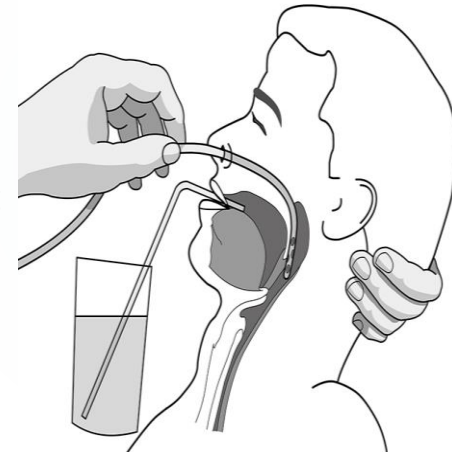


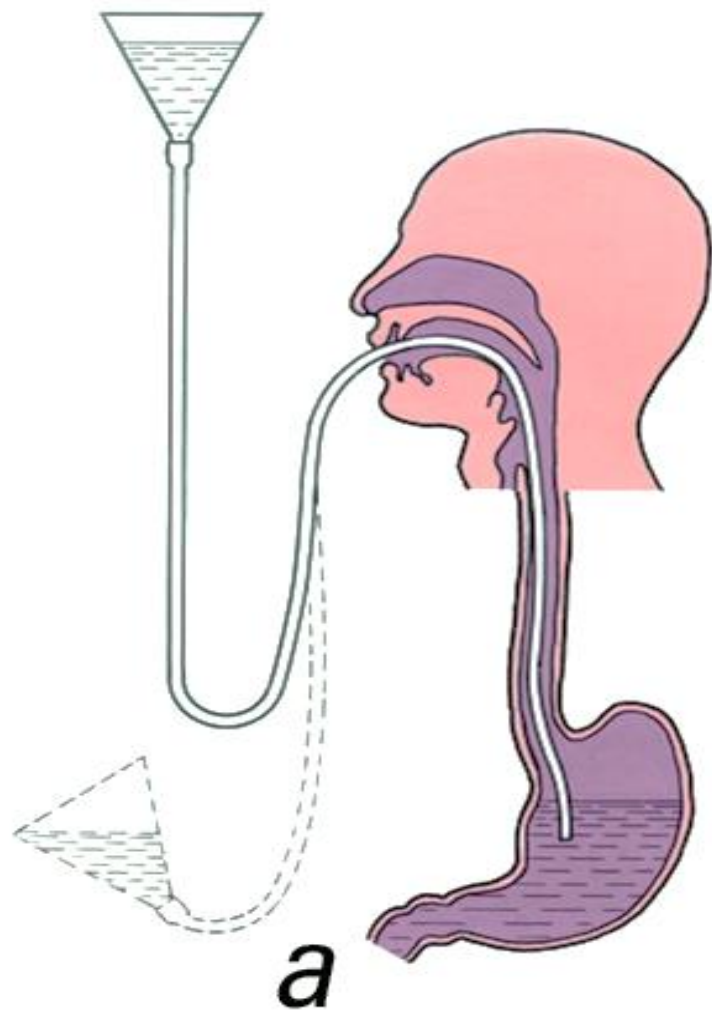
- ▶ Объяснить пациенту ход и суть предстоящей процедуры и получить согласие пациента на проведение процедуры.
- ▶ Вымыть и осушить руки.
- ▶ Подготовить оснащение.
- ▶ Определить расстояние, на которое следует ввести зонд (расстояние от кончика носа до мочки уха и вниз по передней брюшной стенке так, чтобы последнее отверстие зонда было ниже мечевидного отростка). Помочь пациенту принять высокое положение Фаулера.
- ▶ Прикрыть грудь пациента полотенцем / салфеткой.
- ▶ Вымыть и осушить руки.
- ▶ Надеть перчатки.



Выполнение процедуры

- Обильно обработать слепой конец зонда глицерином.
- Попросить пациента слегка запрокинуть голову.
- Ввести зонд через нижний носовой ход на расстояние 15 - 18 см.
- Попросить пациента проглотить (выполнять глотательные движения).
- Помогать пациенту, заглатывать зонд, продвигая его в глотку во время каждого глотательного движения.
- Убедиться, что пациент может ясно говорить и свободно дышать.
- Мягко продвигать зонд до нужной отметки.
- Убедиться в правильном местонахождении зонда в желудке:
 1. Присоединить шприц Жане к зонду и потянуть поршень на себя: в шприц должно поступать содержимое желудка;
 2. Проба Элефанта (elephant): присоединить шприц Жане к зонду и ввести воздух под контролем фонендоскопа (выслушиваются характерные звуки);
 3. Золотой стандарт: Рентгенография ОГК (с захватом эпигастральной области);
 4. У детей раннего возраста – УЗИ ОБП
- Отсоединить шприц от зонда и наложить зажим.
- Зафиксировать зонд (лейкопластырь, тесьма)





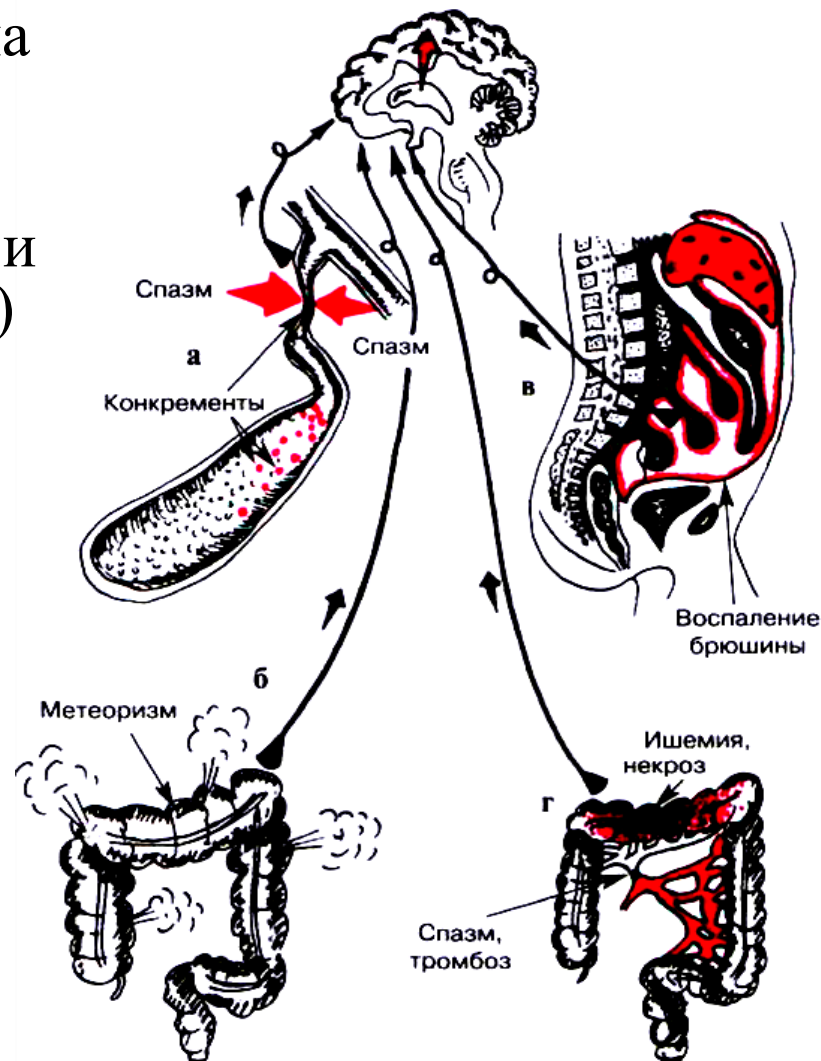


Возраст	Количество воды	
	Одномоментное введение, мл	Полное промывание, л
Новорожденные	15 – 20	0,2
1 – 2 мес	60 – 90	0,3
3 – 4 мес	90 – 100	0,5
5 – 6 мес	100 – 110	0,6
7 – 8 мес	110 – 120	0,7
9 – 12 мес	120 – 150	0,9
2 – 3 года	200 – 250	1 – 2
4 – 5 лет	300 – 350	2 – 3
6 – 7 лет	350 – 400	3 – 4
8 – 11 лет	400.– 450	4 – 5
12 – 15 лет	450 – 500	4 – 5
Старше 15 лет	500	5 – 6

Боли в области живота



- ▶ **Спастические** (в результате спазма гладкой мускулатуры органов)
- ▶ **Дистензионные** (в результате растяжения стенок полых органов и натяжения их связочного аппарата)
- ▶ **Перитонеальные** (в результате перехода воспаления на париетальную брюшину или перфорации (прободения) полых органов)
- ▶ **Сосудистые** (при остром нарушении кровообращения в органах в результате спазма или тромбоза артериальных сосудов)



Локализация боли



- ▶ При патологии **пищевода** (эзофагит, ожоги): за грудиной, могут иррадиировать в межлопаточную область
- ▶ При грыже **пищеводного отверстия диафрагмы**: могут иррадиировать в левую половину грудной клетки, имитировать заболевания сердца
- ▶ При заболеваниях **желудка**: в эпигастральной области, справа от средней линии
- ▶ Иррадиация в спину – при язвах задней стенки **желудка**, при пенетрации в поджелудочную железу
- ▶ Опоясывающие боли – при патологии **поджелудочной железы**
- ▶ При заболеваниях **кишечника** – в любом месте живота

Уход за больными с болевым синдромом



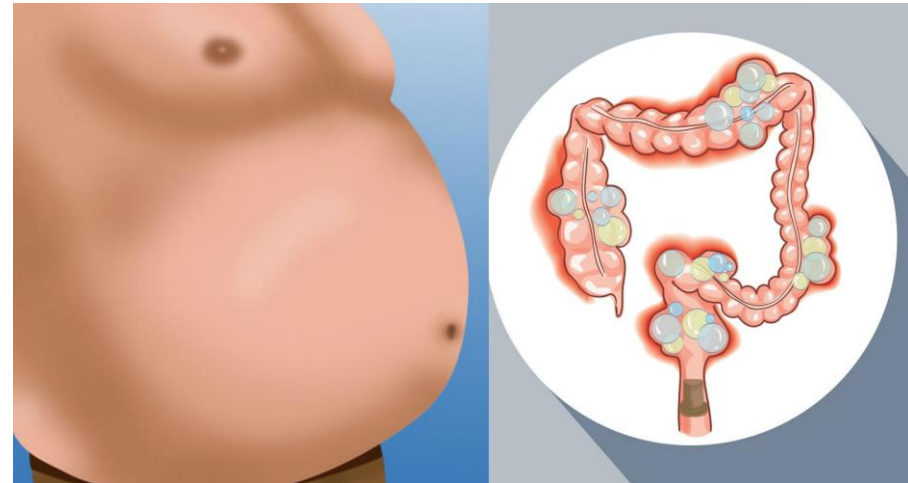
- ▶ Уточнить: локализацию боли, характер боли, периодичность боли, связь с приемом пищи, с чем связано уменьшение болей
- ▶ Вызов врача
- ▶ Мониторинг
- ▶ Назначение тепла или холода возможно после осмотра врача
- ▶ При внезапном появлении сильной боли в животе, сопровождающейся тошнотой и/или рвотой, отсутствие стула (реже – понос), вздутие живота, напряжение брюшной стенки («доскообразный живот») необходимо СРОЧНО вызвать хирурга

Метеоризм

(греч. *meteorismos* – поднятие вверх)



- ▶ Вздутие живота в результате избыточного скопления газов в пищеварительном тракте и нарушением их выведения.
- ▶ Проявляется распирающей схваткообразной болью, ощущением тяжести и распираания в животе; симптомы исчезают после отхождения газов.
- ▶ Больного беспокоят частое отхождение газов (более 20 раз в сутки), отрыжка, икота.
- ▶ При усиленной перистальтике кишечника – громкое урчание в животе.



Уход при метеоризме



- ▶ Исключение из диеты продуктов, употребление которых может привести к метеоризму
- ▶ По назначению врача – ветрогонные средства (укроп, фенхель, тмин, симетикон и др.)
- ▶ Массаж живота
- ▶ Тепло к животу



Газоотводная трубка у детей



1. Объяснить маме / ребёнку цель и ход предстоящей манипуляции и получить согласие
2. Вымыть руки, надеть перчатки
3. Детей грудного возраста уложить на пеленальный стол на спину, под ягодицы подложить клеёнку с пелёнкой; ножки ребёнка слегка прижать к животу. Старшие дети лежат на кушетке или кровати с согнутыми в коленях ногами
4. Смазать закруглённый конец газоотводной трубки вазелиновым маслом
5. Перегнуть трубку, зажать её свободный конец 4 и 5 пальцами правой руки; взять закруглённый конец, как ручку
6. Раздвинуть ягодицы 1 и 2 пальцами левой руки, осторожно вращательными движениями ввести в прямую кишку газоотводную трубку сначала к пупку, затем, преодолев сопротивление внутреннего сфинктера анального отверстия, параллельно копчику (на глубину: новорожденные – 3-4 см, грудные дети – 7-8 см, 1-3 года – 8-10 см, 3-10 лет – 10-15 см, старшим – 20-30 см и более)
7. Опустив её свободный конец в ёмкость с водой
8. Укрыть ребёнка одеялом
9. Извлечь трубку из ануса по достижении эффекта через 5-10 мин., но не более 20 мин. и поместить в лоток с дез.раствором
10. После отхождения газов и каловых масс подмыть ребёнка, обтереть, обработать кожу вокруг анального отверстия детским кремом, одеть ребёнка
11. Убрать клеёнку и пелёнку, поместить их для дезинфекции. Снять и утилизировать перчатки, вымыть и осушить руки.



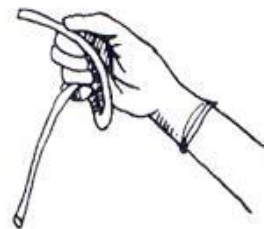
Газоотводная трубка у взрослых



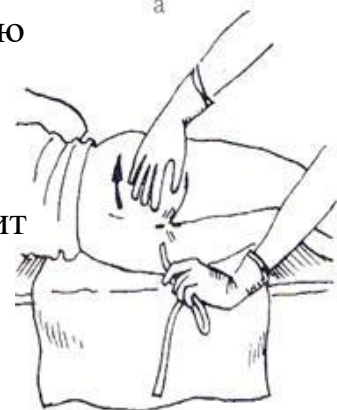
1. Информируйте пациента о предстоящей манипуляции и ходе ее выполнения.
2. Отгородите пациента ширмой.
3. Вымойте руки.
4. Наденьте перчатки.
5. Смажьте узкий конец трубки лубрикантом.
6. Подстелите клеенку.
7. Уложите пациента на левый бок с приведенными к животу ногами.
8. Разведите левой рукой ягодицы пациента и осторожно вращательно-поступательными движениями введите газоотводную трубку на глубину 20 – 30 см. Первые 3 – 4 см по направлению к пупку, а остальные параллельно позвоночнику.
9. Опустите наружный конец газоотводной трубки в подкладное судно или мочеприемник, заполненные на 1/3 водой, что обеспечит наблюдение за выделениями из кишечника.
10. Накройте пациента простыней или одеялом.
11. Извлеките газоотводную трубку по достижении эффекта.
12. Оботрите заднепроходное отверстие салфеткой.
13. Обработайте газоотводную трубку, перчатки, лоток, судно, клеенку в соответствии с требованиями санэпидрежима.
14. Вымойте руки.



а



б



в



г

Кишечные колики у младенцев



- ▶ это внезапные и выраженные приступы плача и беспокойства младенцев продолжительностью 3 и более часов в течение суток не менее 3 дней в неделю на протяжении 3х недель.

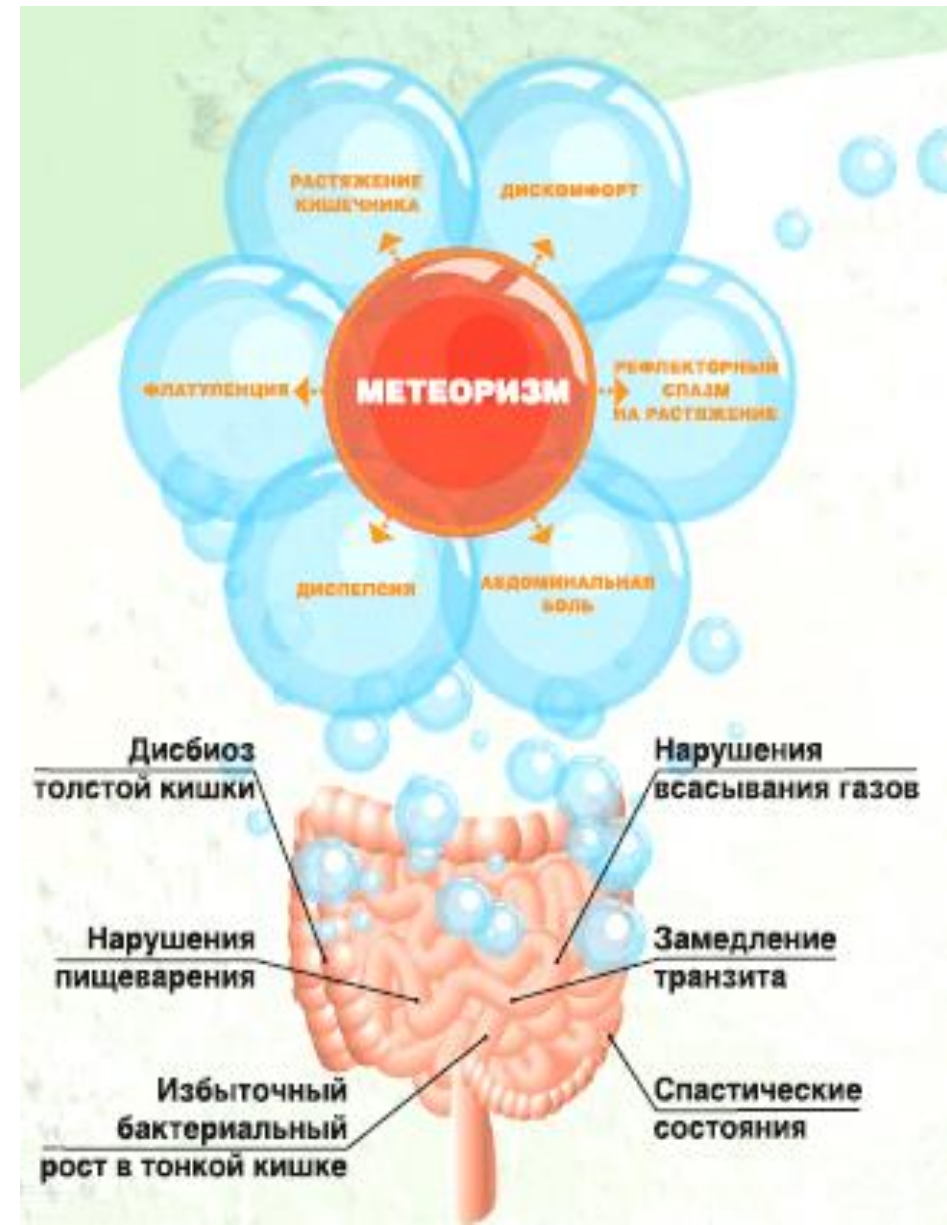
Причины:

- ▶ Морфо-функциональная незрелость периферической иннервации кишечника
- ▶ Дисфункция центральной регуляции
- ▶ Поздний старт развития ферментативных систем
- ▶ Нарушения становления микробиоценоза кишечника



- ▶ Особенность кишечника у детей – развитие циркулярной мускулатуры больше, чем продольной, что предрасполагает к спазмам кишечника и кишечной колике.

- ▶ Аккумулированный в кишечнике газ представляет собой пену, состоящую из множества мелких пузырьков, каждый из которых окружен слоем вязкой слизи.
- ▶ Слизистая пена покрывает тонким слоем слизистую оболочку кишки, что затрудняет пристеночное пищеварение, снижает активность ферментов, затрудняет процессы всасывания, в том числе воды. Из-за слизи нарушаются процессы абсорбции газов кишечной стенкой



Помощь при кишечных коликах



- ▶ **Психоэмоциональное состояние** матери и окружающих родственников.
- ▶ Общие мероприятия создания **спокойного психологического климата в окружении ребенка**: нормализация образа жизни семьи и ребенка, увеличение времени прогулок и сна.
- ▶ Снятие психологического напряжения, **создание ауры уверенности** помогает уменьшить боль у ребенка и правильно выполнить все назначения врача.
- ▶ **Диета маме** (ограничивается цельное коровье молоко, продукты, вызывающие избыточное газообразование – огурцы, майонез, виноград, фасоль, кукуруза, изделия из дрожжевого теста, капуста, экстрактивные вещества (бульоны, приправы); вводятся кисломолочные продукты).
- ▶ **Постуральная терапия.** После кормления необходимо подержать ребенка в наклонном положении (под углом 45-60°, животиком вниз) в течение 10–15 минут, для отхождения проглоченного воздуха.

Общие свойства испражнений



- ▶ Консистенция и форма кала зависят от содержания в нем воды, жира и клетчатки. У здоровых содержание воды в кале составляет около 70%.
- ▶ При запоре кал становится очень плотным (в кале при этом содержится 60% воды).
- ▶ При поносах кал – жидкий, с частицами непереваренной пищи и различными примесями (например, при холере кал имеет вид рисового отвара с хлопьями слизи, при брюшном тифе – вид горохового супа).
- ▶ При преобладании в кишечнике бродильных процессов испражнения рыхлые, пенистые.
- ▶ Суточное количество кала у здорового человека - в среднем 110 г (40 - 260 г), у мужчин масса кала больше, чем у женщин, у молодых – больше, чем у пожилых.



Бристольская шкала

для описания формы и консистенции кала



Тип 1		Отдельные жёсткие куски, похожие на орехи. Трудно продвигается.
Тип 2		Колбасоподобный, но кусковый. Диаметр больше, чем у типа 3.
Тип 3		Выглядит как колбаса, но покрыт трещинами. Диаметр меньше, чем у типа 2.
Тип 4		Выглядит как сосиска или змея. Гладкий и легко поддающийся давлению.
Тип 5		Мягкие легкопроходимые разрывающиеся куски.
Тип 6		Пушистые части с рваными краями. Рыхлый, мягкий стул.
Тип 7		Водянистый, нет кусков. Полностью жидкий.

Отдельные плотные комочки, напоминающие орехи

Кал по форме колбаски, но комковатый

Вид колбаски с трещинами на поверхности

Кал «змейкой» или колбаской, но гладкий и мягкий

Мягкие шариком с ровными, острыми краями

Взбитые комочки фекалий «с обтрепанными» краями и пористой структурой

Водянистые или полностью жидкие фекалии без плотных комочков

Amount



1: smear



2: up to 25%



3: 25-50%



4: >50%

Consistency



A: watery



B: soft



C: formed

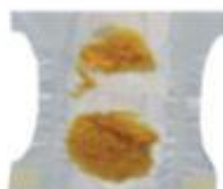


D: hard

Colour



I



II



III



IV



V



VI

Амстердамская шкала оценки стула – шкала Беккали

Для детей раннего возраста

описывает

- **консистенцию стула**
(по 4 пунктам),
- **количество стула**
(по 4 пунктам)
- **цвет стула**
(6 категорий)

Изменение окраски кала

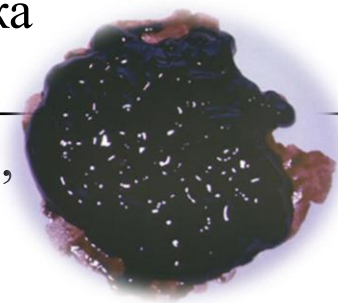


Цвет испражнений	Причины изменения цвета кала
Темно-коричневый	Нормальный кал на смешанной диете
Черно-коричневый	Мясная диета
Светло-коричневый	Растительная диета
Коричнево-красный	Неизменная кровь, пурген, препараты ревеня, марены красильной, употребление в пищу какао, свеклы
Черный	Измененная кровь (кровотечение в верхних отделах пищеварительного тракта), прием висмута, активированного угля, употребление в пищу большого количества печени, кровяной колбасы, черники, смородины, красного вина
Зеленовато-черный	Прием препаратов железа
Зеленый	Билирубин и биливердин при усиленной перистальтике, овощная диета
Золотисто-желтый	При содержании неизмененного билирубина (у грудных детей)
Оранжево-светло-желтый	Молочная диета
Белый или серовато-белый	Обструкция желчных протоков, гепатиты



- ▶ Важный признак **желудочно-кишечного кровотечения**.
- ▶ Черный цвет кала обусловлен наличием солянокислого гематина, образующегося из гемоглобина под воздействием соляной кислоты желудочного сока, и примесей сульфидов, образующихся при действии на кровь различных ферментов и бактерий.
- ▶ Чем выше источник кровотечения, тем более изменена кровь, выделяемая с испражнениями.

Характеристика кала	Источник кровотечения
Черный дегтеобразный	Верхние отделы пищеварительного тракта
Темно-вишневый	Умеренное кровотечение из дистальных отделов тонкой и правой половины толстой кишки
Кала типа «малинового желе» со слизью	Нисходящий отдел толстого кишечника
Алая кровь на поверхности оформленного кала	Нижние отделы кишечника (геморрой, трещины заднего прохода)



Синдром желудочно-кишечного кровотечения (по характеру кала)

Состояние	Характер крови			
	Цвет	Количество	Отношение к калу	Отношение к дефекации
Анальные трещины	Алый, яркий	Мало	На кале полосками	Во время и после
Полипы прямой кишки	Яркий	Мало или много	На кале	Во время и после
Инвагинация	«Малиновое желе»	Мало	Смешана	Во время и после
Язвенный колит	Темный или яркий	Мало или много	Смешана	Во время и после
Кровотечение из желудка и 12-п.к.	Дегтеобразный	Мало или много	Смешана	Во время

Диарея, понос

(греч. *diá* – движение сквозь, *rrhoia* – истечение)



- ▶ Жидкий, неоформленный стул, в большинстве случаев сочетающийся с учащением дефекации (свыше двух раз в сутки).

Возникает вследствие:

- ▶ ускоренной перистальтики кишечника и вследствие этого быстрым продвижением по кишечнику и ускоренной эвакуацией кишечного содержимого;
- ▶ нарушение всасывания жидкости в кишечнике (уменьшение всасывания воды и электролитов в кишечнике);
- ▶ увеличение патологической секреции жидкости в кишечнике при его воспалении (усиленная секреция в полость кишечника и повышенное слизиобразование).



Основные причины диареи



- ▶ Воспаление слизистой оболочки желудка (гастрит), кишечника (энтериты, колиты)
- ▶ Снижение секреторной функции желудка (ахилия), сопровождающееся нарушением переваривания белков и быстрым опорожнением желудка
- ▶ Снижение внешнесекреторной функции поджелудочной железы (панкреатит, рак)



Клинические особенности диареи



Энтеральный понос

- умеренное учащение стула (до 4-6 раз в сутки)
- очень обильные испражнения, в которых содержатся остатки непереваренной пищи,
- стеаторея («жирный» кал)
- нередко боли вокруг пупка

Желудочный понос

- умеренное учащение стула (до 4-6 раз в сутки)
- испражнения жидкие, темного цвета, с остатками непереваренной пищи, нередко с неприятным гнилостным запахом, со слизью
- часто с чувством переполнения и тупыми распирающими болями в эпигастрии

Колитический понос

- очень частый стул (10–15 раз в сутки)
- сопровождается тенезмами (болезненными позывами к дефекации)
- испражнения скудные, часто с примесью слизи и крови.

Панкреатический понос:

- умеренное учащение стула
- испражнения обильные (полифекалия), кашицеобразные или жидкие, со слизью
- стеаторея и неприятный гнилостный запах
- сопровождается болями в верхней половине живота, иногда опоясывающего характера, метеоризмом

Механизмы развития диареи



Секреторная диарея



Развивается в результате повышенного выделения воды и натрия в просвет кишки

Осмотическая диарея



Возникает при нарушении пищеварения и является следствием накопления в просвете кишки осмотических активных веществ, вызывающих выход воды и натрия в полость кишки

Экссудативная диарея



Обычно обусловлена воспалительными заболеваниями кишечника

Моторная диарея



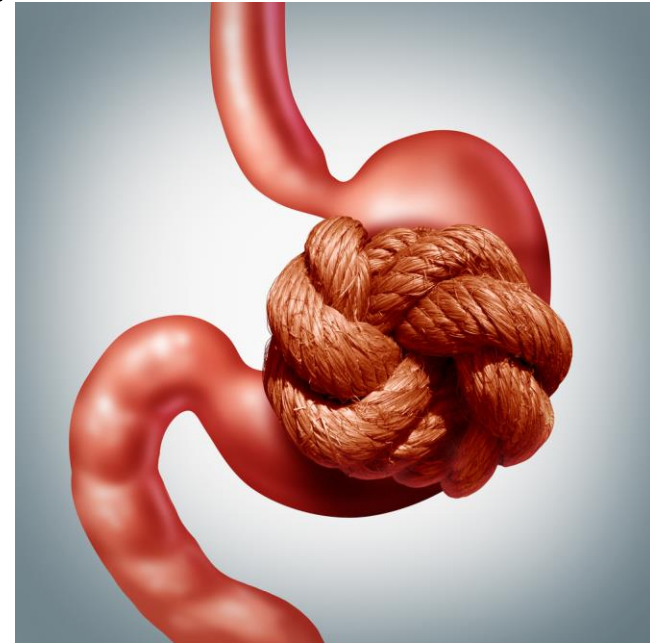
Чаще всего характеризуется ускорением транзита пищевого комка на фоне активной двигательной функции кишечника

Констипация, запор

(лат. *constipatio* – скопление, нагромождение)



- ▶ Длительная (больше 3 суток) задержка кала в кишечнике или редкое, затрудненное опорожнение кишечника незначительным количеством кала (менее 100 г в сутки) с ощущением неполного опорожнения кишечника.
- ▶ Запор обусловлен:
 - замедлением перистальтики кишечника,
 - механическими препятствиями в кишечнике,
 - алиментарным фактором.



Основные причины запора



- ▶ воспалительные заболевания кишечника,
- ▶ наличие препятствия на пути кишечного пассажа (механическая непроходимость) – например, опухоль в брюшной полости, глисты, сдавление кишечника увеличенной маткой, полипы в прямой кишке и др.,
- ▶ заболевания, замедляющие перистальтику нижних отделов кишечника (геморрой, трещины и свищи заднего прохода, парапроктит),
- ▶ экзогенные интоксикации (хронические профессиональные отравления свинцом, ртутью, таллием, висмутом; морфинизм, никотинизм),
- ▶ эндогенные интоксикации (например, при хронической почечной недостаточности),
- ▶ заболевания эндокринной системы (гипотиреоз, сахарный диабет и др.),
- ▶ нарушения водно-электролитного обмена (обезвоживание, дефицит калия, сердечная недостаточность и др.),
- ▶ психические нарушения (депрессия, нервная анорексия),
- ▶ неврологические нарушения (инсульт, вегетативная нейропатия),
- ▶ нарушение диеты и режима питания

Ятрогенные причины запора



- ▶ применение лекарственных средств, угнетающих двигательную активность кишечника: наркотические анальгетики, антидепрессанты, нестероидные противовоспалительные средства, β -адреноблокаторы, антагонисты кальция, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и др.)
- ▶ применение лекарственных препаратов, способствующих обезвоживанию организма – например, мочегонных препаратов
- ▶ неврогенные факторы (например, подавление физиологического позыва на низ вследствие неудовлетворительных бытовых условий)
- ▶ гиподинамия (запор у больных, длительно находящихся на постельном режиме)

Виды запоров



- ▶ **Атонические запоры** – атония кишечника в результате слабости кишечной мускулатуры и пониженной раздражимости кишечной стенки, а также при заболеваниях соседних органов. Содержимое кишечника задерживается в толстой кишке до 7 и более суток.
- ▶ **Спастические запоры** – усилена двигательная активность – моторика кишечника, однако над продольными превалируют сегментарные движения кишечника, что препятствует транспорту кишечного содержимого. Каловые массы оформлены в виде шариков («овечий кал»), лент («карандаш»), комочков и др. При длительной задержке стула формируются твердые каловые массы – «каловые камни».
- ▶ **Органические запоры** обусловлены механическим препятствием для продвижения каловых масс по кишечнику (опухоли кишечника, рубцы, спайки, мегаколон, долихосигма).

Сестринская помощь при запорах



- ▶ Поддержание диеты: (чёрный хлеб, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, хлеб, содержащий значительное количество отрубей; крупы гречневая, ячневая, овсяная; мясо с большим количеством соединительной ткани; соленья, маринады; безалкогольные напитки (минеральные воды, лимонад, соки), пиво, квас, сметана, сливки; кисломолочные продукты (простокваша, однодневный кефир, белые виноградные вина).
- ▶ Больным с запором и жалобами на вздутие живота ограничивают или даже исключают из рациона продукты, богатые пищевыми волокнами. Исключают вызывающие повышенное газообразование блюда из бобов, капусты, щавеля, шпината и др. Из фруктовых соков не рекомендуются яблочный, виноградный.
- ▶ При запорах, сопровождающихся выраженной перистальтикой кишечника, особенно при наличии спастических болей в животе применяют диету с низким содержанием пищевых волокон.
- ▶ Если нет специальных противопоказаний (болезни сердца, отёки), то больной, страдающий запорами, должен выпивать в сутки примерно 1,5–2 л жидкости.
- ▶ Больным с запорами показаны минеральные воды. При запорах с повышенной сократительной деятельностью кишечника, при болях в животе предпочтительнее приём тёплой минеральной воды.
- ▶ При наличии показаний – клизмы

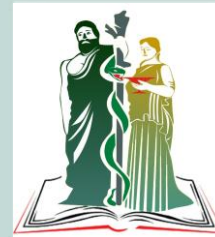
Выработка рефлекса на дефекацию с 6 месячного возраста



- ▶ Выработка условного рефлекса на дефекацию является чрезвычайно важным аспектом лечения запоров у детей.
- ▶ Длительное применение у детей раннего возраста подгузников приводит к тому, что ребенок привыкает очищать кишечник стоя или лежа, не в горшок, а только в подгузники.

1. Утром, натощак, выпить минеральную воду комнатной температуры, которая оказывает мощное стимулирующее влияние на моторную функцию кишечника.
2. Завтрак (через 20–30 минут после приема минеральной воды).
3. Регулярное посещение туалета (высаживание на горшок) в одно и то же время, желательно после завтрака. Следует обратить особое внимание на то, что ребенок в туалете должен опираться на ножки, держать спинку прямо.
4. Для преодоления «боязни горшка» у детей с нормальным стулом тоже можно воспользоваться препаратами Лактулозы.



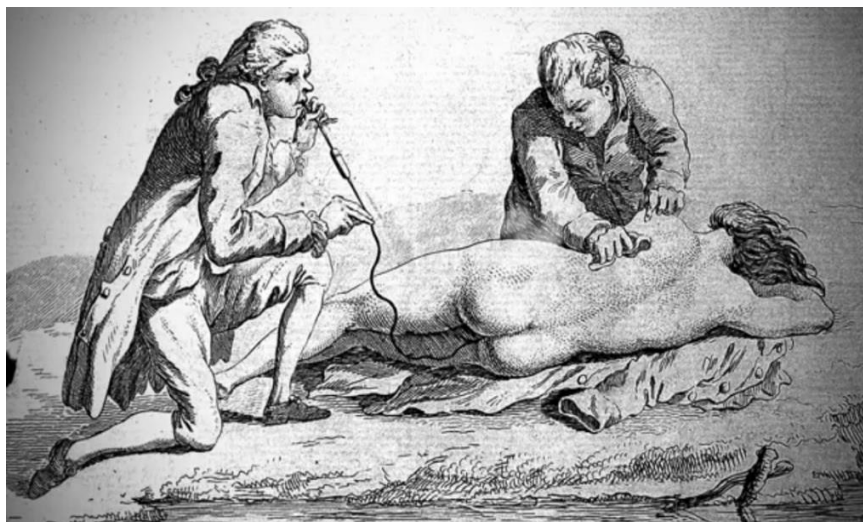


Лечебно- диагностические процедуры. Клизмы.

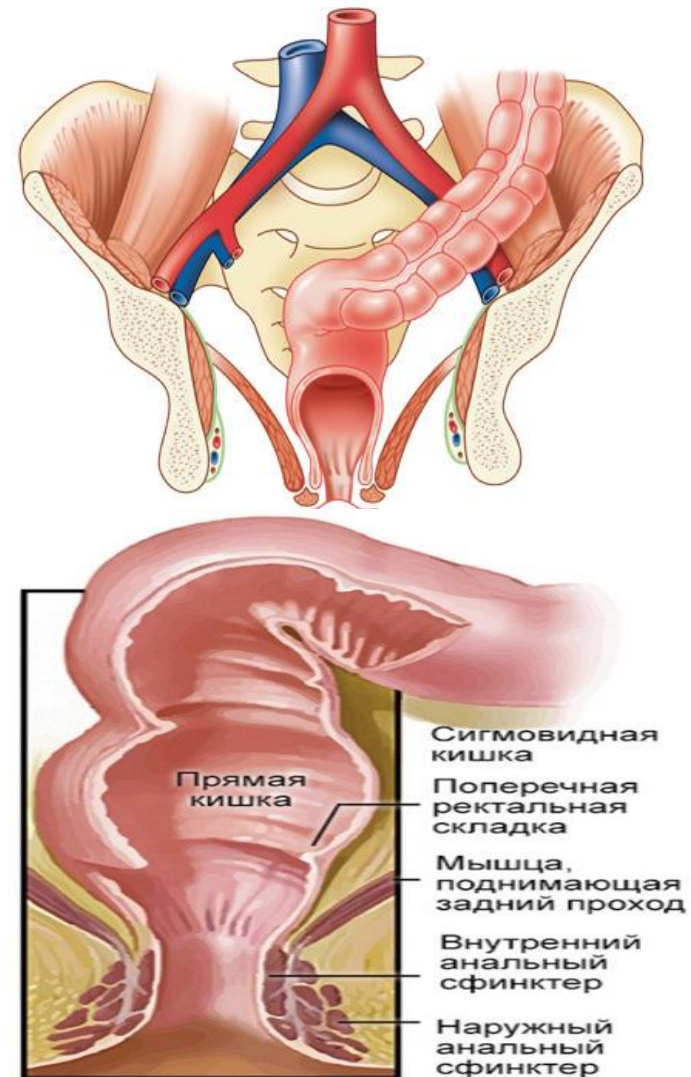
Клизма



- ▶ греч. klyisma - промывание
- ▶ Медицинская процедура, заключающаяся во введении воды или иных жидкостей либо растворов лекарственных веществ через анальное отверстие в прямую кишку (с использованием стандартных наконечников для клизм) или непосредственно в толстую кишку (с использованием длинных кишечных трубок или наконечников для глубоких клизм).



Толстая кишка





**В зависимости
от цели**

Очистительные и
послабляющие
клизмы;

Лекарственные

Питательные
(капельные) клизмы

Диагностические
клизмы

Ритуальные клизмы

Классификация клизм по цели использования



- ▶ **Очистительные клизмы** — с целью очищения и промывания толстой кишки, ликвидации запора или калового завала, лечения какого-либо отравления или интоксикации, перед некоторыми хирургическими операциями, родами.
- ▶ **Лечебные (лекарственные) клизмы** — микроклизмы (10-100 мл), используемые с целью введения в прямую и сигмовидную кишку растворов лекарственных веществ (отваров трав, растворов лекарственных препаратов, суспензий биологических препаратов), предназначенных для их удержания в прямой кишке не менее 30 минут до всасывания или с последующим опорожнением кишечника.
- ▶ **Питательные (капельные) клизмы** — введение жидкости в объёме 0,5-1,0 л проводится медленно.



По количеству вводимой жидкости



- ▶ **Микроклизма** – введение жидкости в объёме 10-100 мл.
Используется для введения лекарственных препаратов.
- ▶ **Очистительная клизма** – введение жидкости в объёме 1,5-2 литра.
Используется для очищения толстой кишки при запоре или перед проведением диагностических исследований прямой и ободочной кишки (эндоскопических, рентгенологических).
- ▶ **Сифонная клизма** (син.: кишечное промывание) – введение жидкости в суммарном объёме 15-20 литров на одну процедуру путем многократного вливания и выливания жидкости по 1-2 литра.
Используется для выведения из организма токсических веществ, глубокого очищения толстой кишки.

По составу вводимых растворов



- ▶ **Простые (водные) клизмы** — применяются чаще всего при запорах, перед родами, для очистки кишечника перед хирургическими операциями.
- ▶ **Лекарственные клизмы** — клизмы с растворами лекарственных препаратов или отварами лекарственных трав, например ромашки.
- ▶ **Мыльные клизмы** — клизмы с мыльным раствором. Применяются в основном при запорах как стимулятор перистальтики толстой кишки. Часто при этом мыло комбинируется с глицерином, также являющимся сильным стимулятором перистальтики толстой кишки.
- ▶ **Глицериновые клизмы** — клизмы с чистым глицерином либо с водным раствором глицерина. Применяются в основном при запорах как стимулятор перистальтики толстой кишки.
- ▶ **Масляные клизмы** — клизмы с растительным или минеральным (вазелиновым) маслом. Применяются в основном при упорных запорах, а также как смазка и защита слизистой толстой кишки от излишнего раздражения перед введением мыльной или глицериновой клизмы.

Клизма по Огневу



- ▶ Предложена старшим ординатором проктологического отделения Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского Огневым Валентином Петровичем
- ▶ Обладает сильным раздражающим действием.
- ▶ 20 мл 3 % пероксида водорода, 20 мл чистого (безводного) глицерина и 20 мл мыльного раствора (раньше использовали 100 мл сухого вина).
- ▶ Применяется только при полной атонии или значительном парезе толстой кишки, например, послеоперационном парезе толстой кишки. Не применяется в тех случаях, когда противопоказан пероксид водорода.

По температуре



- **Холодная клизма** – клизма с холодной жидкостью (T – от 0 до комнатной, но ниже комнатной). Сильно стимулирует перистальтику толстой кишки, снижает температуру тела. Применяется при атонических запорах, атонии или парезе толстой кишки, при необходимости минимизировать всасывание введенной жидкости.
- **Прохладная клизма** – клизма с жидкостью комнатной температуры. Применяется при атонических запорах, при гипертермии.
- **Теплая клизма** – клизма с жидкостью температуры тела, измеренной в прямой кишке, или чуть выше температуры тела ($37-39\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $40\text{ }^{\circ}\text{C}$). Расслабляет толстую кишку, оказывает спазмолитическое действие, не сильно стимулирует моторику кишечника. Лучше растворяет кал, лучше всасывается. Не влияет на температуру тела. Применяется при спастических запорах, спазмах гладкой мускулатуры толстой кишки и прилегающих к толстой кишке органов.
- **Горячая клизма** – клизма с жидкостью температуры между 40 и $45\text{ }^{\circ}\text{C}$. Субъективно воспринимается как горячая, но не чрезмерно горячая, не обжигающая. Вызывает более сильные спазмы и позывы на дефекацию, чем теплая клизма, но менее сильные, чем холодная. Применяется в основном как средство согревания простаты при простатите у мужчин.

Способы введения жидкости



- ▶ **Гидравлический:** жидкость поступает из резервуара, расположенного выше уровня тела пациента;
- ▶ **Нагнетательный:** жидкость вводят в кишечник специальным резиновым баллоном (спринцовкой, грушей) ёмкостью 200-250 мл, или шприцем Жанэ



Абсолютные

противопоказания для клизм



- ▶ желудочно-кишечные кровотечения,
- ▶ острые воспалительные процессы в толстой кишке,
- ▶ острые воспалительные или язвенно-воспалительные процессы в области заднего прохода,
- ▶ злокачественные новообразования прямой кишки (симптом Цеге-Монтейфеля),
- ▶ острый аппендицит, перитонит,
- ▶ первые дни после операций на органах пищеварения,
- ▶ кровотечение из геморроидальных узлов,
- ▶ выпадение прямой кишки.

Техническая подготовка к процедуре



- ▶ Надеть специальную униформу для работы в клизменной (клеенчатый фартук, шапочку, перчатки, при необходимости – защитные очки).
- ▶ В листе назначения выяснить, ФИО пациента, возраст пациента, цель постановки клизмы
- ▶ Обработать руки гигиеническим способом
- ▶ Собрать все необходимое для манипуляции: кружка Эсмарха, зажим, стерильный наконечник, нестерильные перчатки, лубрикант, туалетная бумага, емкость с водопроводной водой комнатной температуры 1,5-2 литра, ведро, клеенка, одноразовая пеленка, штатив, контейнер для отходов класса А, контейнер для отходов класса Б, контейнер для дезинфекции перчаток, пинцет.
- ▶ Проверить готовность собранного материала, срок годности и целостность стерильного наконечника, кружки Эсмарха, лубриканта, целостность упаковки зажима.
- ▶ Вскрыть стерильную упаковку кружки Эсмарха и повесить кружку Эсмарха на штатив, упаковку от кружки утилизировать в контейнер для отходов класс «А».
- ▶ Вскрыть стерильную упаковку зажима, проверить работоспособность замка зажима, наложить зажим на резиновую трубку кружки Эсмарха, на расстояние 5 см от конца трубки, повесить зажим на штатив.
- ▶ Заполнить кружку Эсмарха водой на 2/3 ее объема
- ▶ Взять стерильный наконечник коннекторной частью кверху, вскрыть упаковку со стороны коннектора, присоединить стерильный наконечник к трубке, плотно, не снимая упаковки

Психологическая подготовка пациента



- ▶ выявить наличие противопоказаний;
- ▶ рассказать о характере манипуляции, о необходимости и цели выполнения;
- ▶ получить информированное добровольное согласие (по возможности)
- ▶ рассказать об ощущениях во время манипуляции и после неё

Приложение №1
к договору на предоставление
платных медицинских услуг

Информированное добровольное согласие

на виды медицинских вмешательств, включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи

Я, _____

(Ф.И.О. гражданина или законного представителя)

« ____ » _____ г. рождения, проживающий по адресу:

(адрес гражданина или законного представителя)

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Минздрава России от 23 апреля 2012 г. № 390н (зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2012 г. № 24082), (далее – Перечень видов медицинских вмешательств) при оказании мне или лицу, чьим законным представителем Я являюсь (ненужное зачеркнуть) в ООО «ЮлиКлиника ЭКСПЕРТ».

(Ф.И.О. лица, от имени которого, выступает законный представитель)

« ____ » _____ г. рождения, проживающий по адресу:

(адрес лица, от имени которого, выступает законный представитель)

Медицинским работником _____

(должность, Ф.И.О. медицинского работника)

Я ознакомлен с Перечнем видов медицинских вмешательств, в доступной для Меня форме мне даны разъяснения о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что при оформлении настоящего добровольного информированного согласия, а также перед осуществлением медицинского вмешательства, включенного в Перечень видов медицинских вмешательств, Я имею право отказаться от одного или нескольких вышеуказанных видов медицинского вмешательства за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2011. №48, ст. 6724; 2012. №26, ст.3442, 3446).

Сведения о выбранных Мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» может быть передана информация о состоянии Моего здоровья или состоянии лица, законным представителем которого Я являюсь (ненужное зачеркнуть)

(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон)

(подпись)

(Ф.И.О. гражданина или законного представителя)

(подпись)

(Ф.И.О. медицинского работника)

« ____ » _____ г.
(дата оформления информированного добровольного согласия)

Физиологическая подготовка



- ▶ Обеспечить изоляцию пациента во время проведения манипуляции (проведение в клизменной или изоляция ширмами).
- ▶ Клизменная должна быть расположена близко к туалету.
- ▶ Пациент укладывается на кушетку на левый бок с приведёнными к животу ногами.



Очистительная клизма



► Цели:

- очистительная — опорожнение нижнего отдела толстой кишки путём разрыхления каловых масс и усиления перистальтики;
- диагностическая — как этап подготовки к операциям, родам и инструментальным методам исследования органов брюшной полости;
- лечебная — как этап подготовки к проведению лекарственных клизм.

► Показания:

запоры, отравления, уремия, клизмы перед операциями или родами, для подготовки к рентгенологическому, эндоскопическому или ультразвуковому исследованию органов брюшной полости, перед постановкой лекарственной клизмы.

► Противопоказания:

абсолютные противопоказания для всех видов клизм.

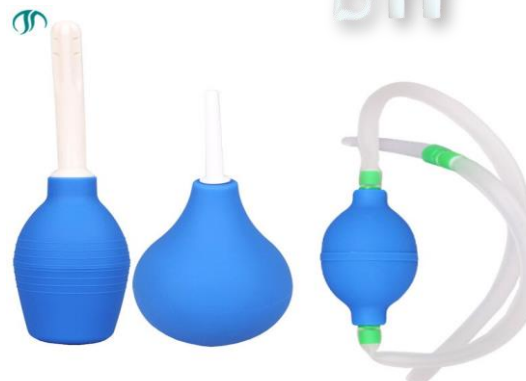
Оборудование



- Кружка Эсмарха (сосуд ёмкостью до 2л).
- Толстостенная резиновая трубка диаметром просвета 1 см, длиной 1,5 м, которую соединяют с тубусом кружки Эсмарха.
- Соединительная трубка с краном (вентилем) для регуляции тока жидкости.
- Наконечник стеклянный, эбонитовый или резиновый.
- Штатив для подвешивания кружки Эсмарха
- Кушетка, ширма, клеенка, пеленка
- Вазелин / глицерин
- Подкладное судно, таз.
- Для медицинской сестры – клеенчатый фартук, перчатки, маску.
- Емкость с дезинфицирующим раствором, контейнеры для отходов класс «А» и «Б»
- Стерильные марлевые салфетки



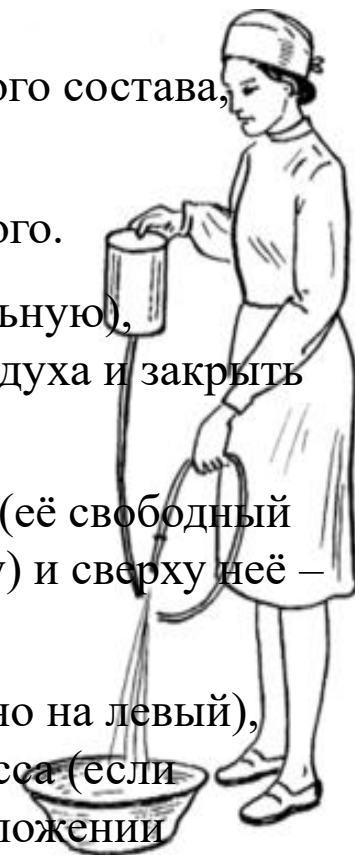
Виды кружек



Порядок выполнения процедуры (1)



1. Подготовиться к проведению процедуры: тщательно вымыть руки с мылом тёплой проточной водой, надеть маску, фартук и перчатки.
2. Налить в кружку Эсмарха кипячёную воду или жидкость назначенного состава, объёма (как правило, 1–1,5 л) и температуры.
3. Подвесить кружку на штатив на высоту 1 м над уровнем тела больного.
4. Открыть кран, заполнить трубки (длинную резиновую и соединительную), выпустить несколько миллилитров воды для вытеснения из трубок воздуха и закрыть кран.
5. Поставить на пол около кушетки таз; на кушетку положить клеёнку (её свободный конец опустить в таз на случай, если больной не сможет удержать воду) и сверху неё – пелёнку.
6. Предложить больному лечь на край кушетки на бок (предпочтительно на левый), согнув колени и приведя их к животу для расслабления брюшного пресса (если больному противопоказано движение, клизму можно поставить и в положении пациента на спине, подложив под него судно); пациент должен максимально расслабиться и дышать глубоко, ртом, не напрягаясь.



Порядок выполнения процедуры (2)



7. Смазать наконечник клизмы лубрикантом (вазелин, глицерин).
8. Большим и указательным пальцами левой руки раздвинуть ягодицы, а правой рукой лёгкими вращательными движениями осторожно ввести в анальное отверстие наконечник, продвигая его вначале по направлению к пупку на 3-4 см, затем параллельно позвоночнику до общей глубины 7-8 см.
9. Приоткрыть кран, следя за тем, чтобы вода не поступала в кишечник слишком быстро, так как это может вызвать боль. Если у больного появилась боль в животе, необходимо немедленно приостановить процедуру и подождать, пока боль не пройдёт. Если боль не утихает, нужно сообщить врачу.
10. Если вода не идёт, поднять кружку выше и/или изменить положение наконечника, выдвинув его назад на 1-2 см; если вода по-прежнему не поступает в кишечник, извлечь наконечник и заменить его (так как он может быть забит каловыми массами).
11. По окончании процедуры закрыть кран и извлечь наконечник, прижав правую ягодицу больного к левой, чтобы не вытекла жидкость из прямой кишки.

Порядок выполнения процедуры (3)



12. Предложить больному самому сжать анальный сфинктер и задержать воду как можно дольше (не менее 5-10 мин).

13. Если через 5-10 мин пациент почувствует позыв к дефекации, подать ему судно или проводить до унитаза, предупредив, чтобы он по возможности выпускал воду не сразу, а порциями.

14. Убедиться, что процедура прошла эффективно; если больной опорожнился только водой с небольшим количеством каловых масс, после осмотра пациента врачом клизму необходимо повторить.

15. Разобрать систему, поместить в ёмкость с дезинфицирующим раствором.

16. Снять фартук, маску, перчатки, вымыть руки.





а



б



в



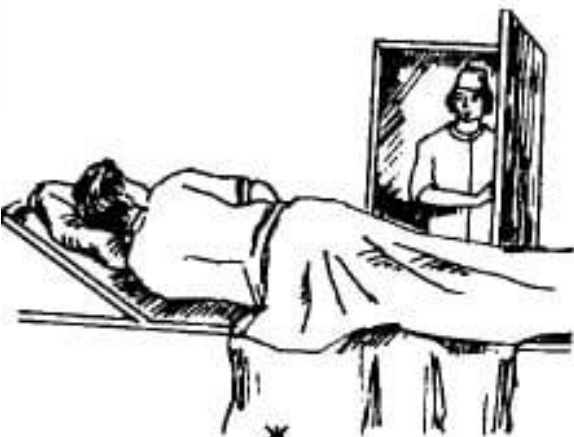
г



д



е



ж



з



и

Положения и упражнения, способствующие лучшему промыванию кишечника



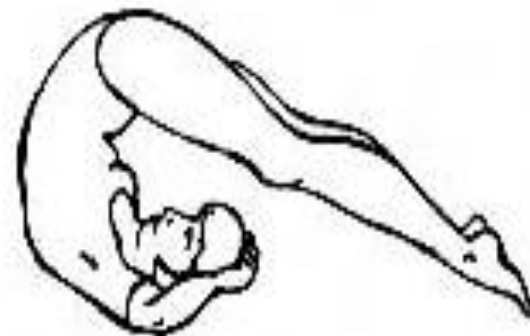
а)



в)



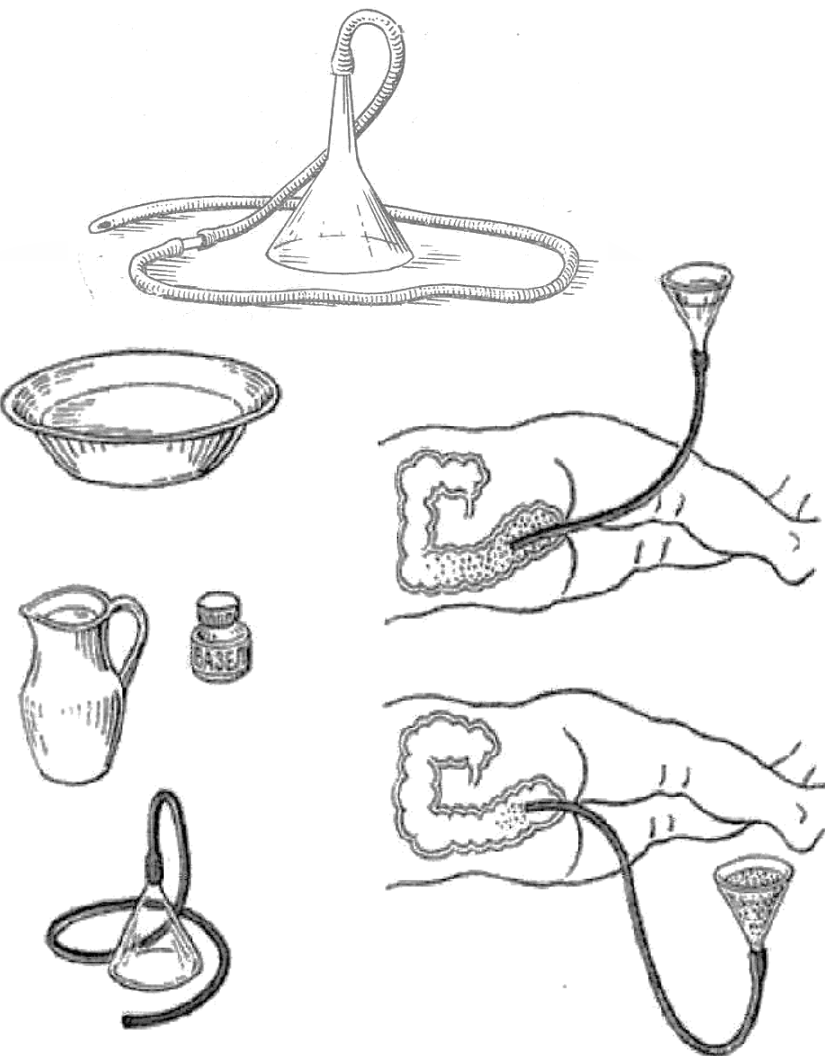
г)



б)



Сифонная клизма



▶ Цель:

Добиться отхождения каловых масс, газов из ВЫСОКИХ отделов кишечника.

▶ Показания:

- Отсутствие эффекта от очистительной клизмы.
- Выделение из кишечника отравляющих веществ.
- Подозрение на кишечную непроходимость.
- Перед проведением ФКС.

Порядок выполнения (1)



1. Подготовиться к проведению процедуры: тщательно вымыть руки с мылом тёплой проточной водой, надеть маску, фартук и перчатки.
2. Поставить на пол около кушетки таз; на кушетку положить клеёнку (свободный конец которой опустить в таз) и сверху неё – пелёнку.
3. Попросить больного лечь на край кушетки, на левый бок, согнув колени и приведя их к животу для расслабления брюшного пресса.
4. Приготовить систему, обработать наконечник лубрикантом.
5. Большим и указательным пальцами левой руки раздвинуть ягодицы, а правой рукой лёгкими вращательными движениями осторожно ввести в анальное отверстие зонд на глубину 30-40 см.
6. Расположить воронку в наклонённом положении чуть выше уровня тела больного и наполнить её с помощью ковша водой в количестве 1 л.
7. Медленно поднять воронку на 0,5 м над уровнем тела пациента.

Порядок выполнения (2)



8. Как только уровень убывающей воды достигнет устья воронки, опустить воронку ниже уровня тела пациента и дожидаться заполнения воронки обратным током жидкости (воды с частицами кишечного содержимого).

Нельзя допускать убывания воды ниже устья воронки во избежание попадания в трубку воздуха. Попадание в систему воздуха нарушает реализацию принципа сифона; в этом случае следует начать процедуру заново.

9. Повторить промывание до появления в воронке чистых промывных вод.

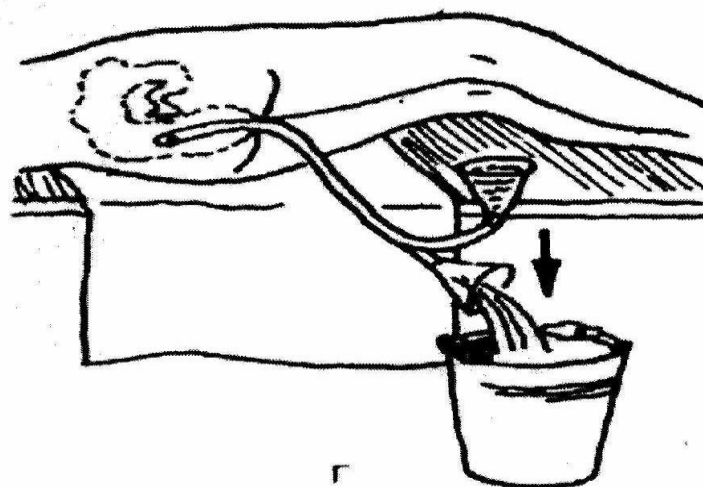
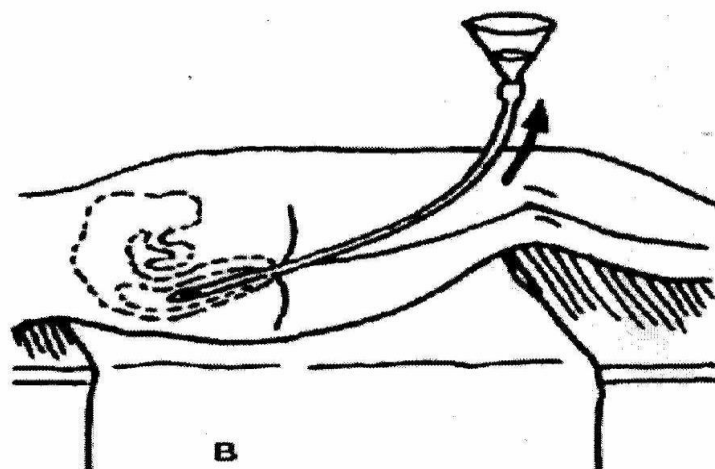
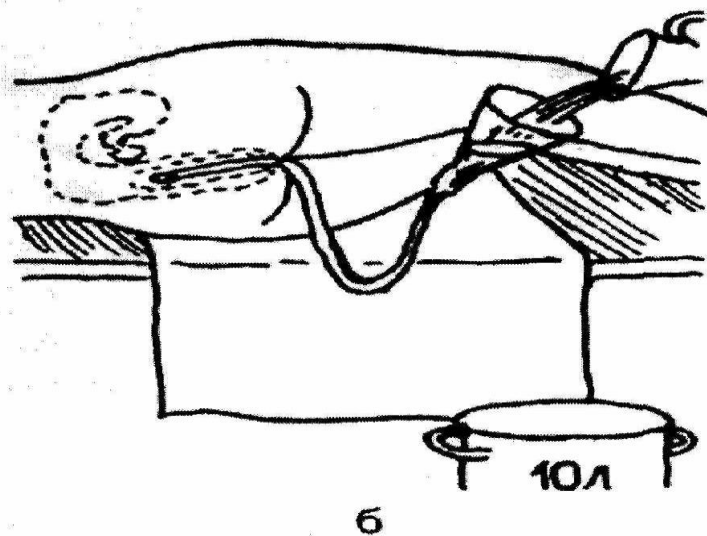
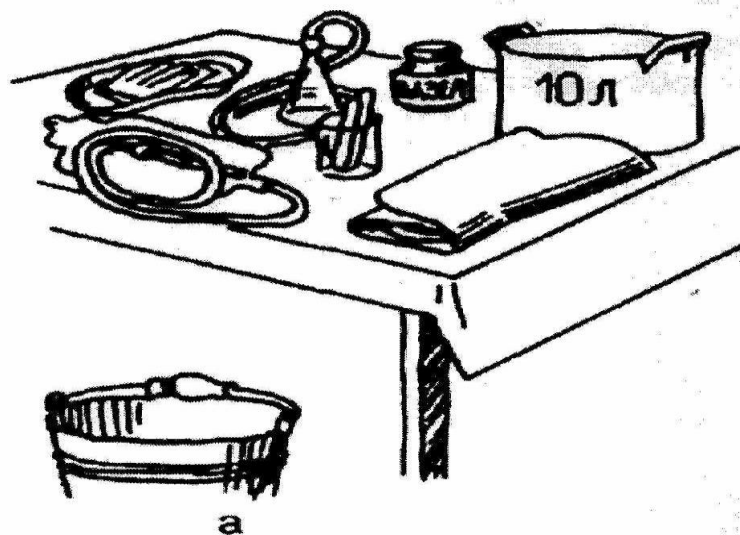
10. Медленно извлечь зонд и погрузить его вместе с воронкой в ёмкость с дезинфицирующим раствором.

11. Провести туалет анального отверстия.

12. Снять фартук, маску, перчатки, вымыть руки.

13. Следует внимательно следить за состоянием больного во время проведения процедуры, поскольку большинство пациентов плохо переносят сифонную клизму.

14. Слить содержимое воронки в таз. При отравлении из первой порции промывных вод необходимо взять 10-15 мл жидкости для токсикологического исследования.



Послабляющая клизма: гипертоническая



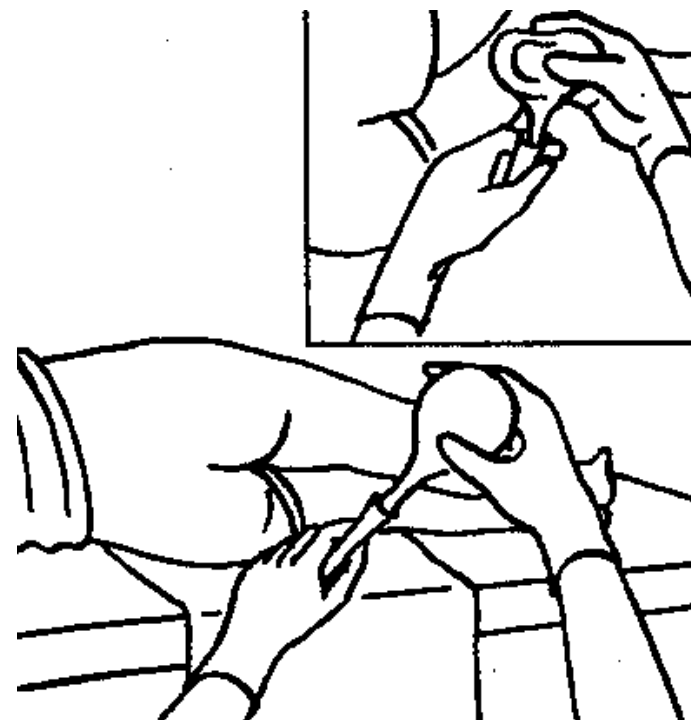
- ▶ применяют при упорных запорах, а также при парезе кишечника, когда введение больному большого количества жидкости неэффективно или противопоказано.
- ▶ Гипертоническая клизма обеспечивает эффективное очищение кишечника, способствуя обильной транссудации воды из капилляров кишечной стенки в просвет кишки и выведению из организма большого количества жидкости.
- ▶ Кроме того, гипертоническая клизма стимулирует выделение обильного жидкого стула, мягко усиливая перистальтику кишечника.
- ▶ Показания: неэффективность очистительной клизмы, массивные отёки.
- ▶ Противопоказания: общие - абсолютные противопоказания для всех видов клизм).

Растворы для гипертонической клизмы



- 10% раствор натрия хлорида;
- 25% раствор магния сульфата;
- 20-30% раствор натрия сульфата.

- ▶ Для постановки гипертонической клизмы назначенный раствор (50-100 мл) подогревают до температуры 37-38 °С.
- ▶ Необходимо предупредить больного, чтобы он не вставал сразу после клизмы и постарался задержать раствор в кишечнике на 20-30 мин.



Послабляющая клизма: масляная



- ▶ способствует лёгкому отхождению обильного стула даже в тех случаях, когда введение в кишечник воды неэффективно.
- ▶ Действующие факторы:
 - механический — масло проникает между кишечной стенкой и каловыми массами, размягчает кал и облегчает выведение его из кишечника;
 - химический — масло не всасывается в кишечнике, но частично омыляется и расщепляется под воздействием ферментов, снимая спазм и восстанавливая нормальную перистальтику.
- ▶ **Показания:** неэффективность очистительной клизмы, спастический запор, длительные запоры, когда нежелательно напряжение мышц брюшной стенки и промежности; хронические воспалительные заболевания толстой кишки.
- ▶ **Противопоказания:** общие — абсолютные для всех видов клизм).

Растворы для масляной КЛИЗМЫ



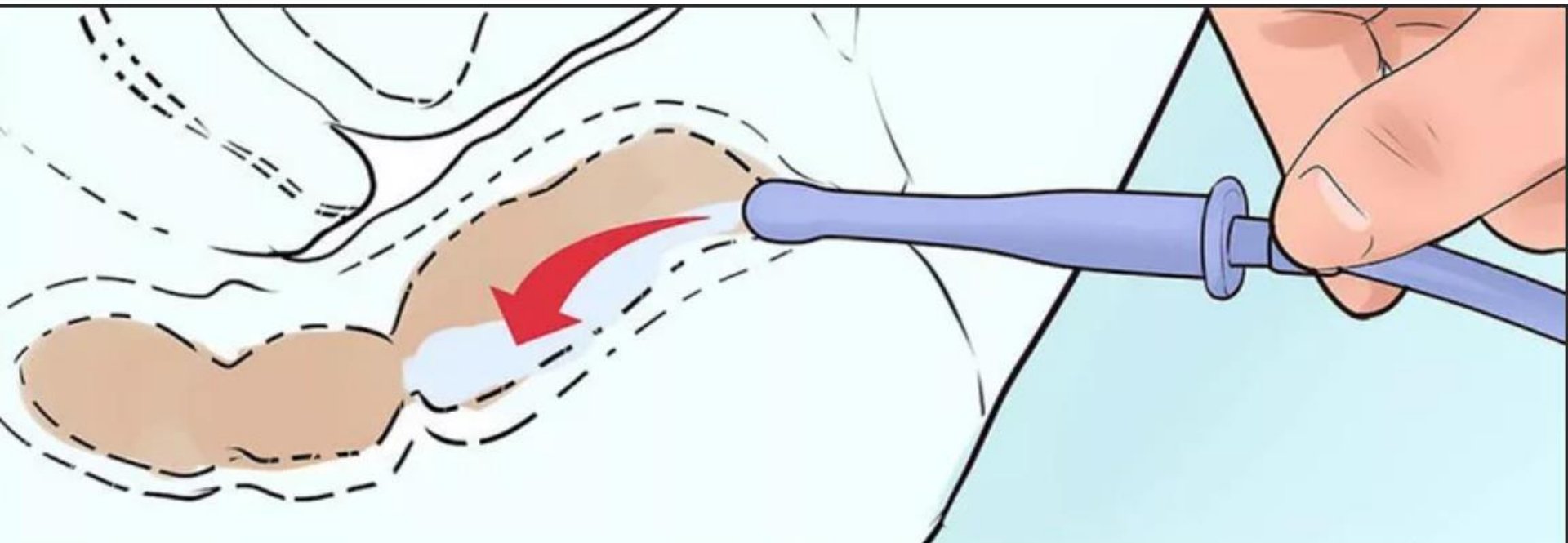
- ▶ Применяют растительные масла (подсолнечное, льняное, конопляное) или вазелиновое масло.
- ▶ Назначенное масло (100-200 мл) подогревают до температуры 37-38 °С.
- ▶ Масляную клизму обычно ставят на ночь, причём больного необходимо предупредить, что после клизмы он не должен вставать с постели до тех пор, пока не подействует клизма (обычно через 10-12 ч).



Послабляющая клизма: эмульсионная



- ▶ назначают тяжелобольным, при ней полное опорожнение кишечника обычно наступает через 20-30 мин.
- ▶ Для постановки эмульсионной клизмы применяют эмульсионный раствор, состоящий из 2 стаканов настоя ромашки, взбитого желтка одного яйца, 1 ч.л. натрия гидрокарбоната и 2 ст.л. вазелинового масла или глицерина.

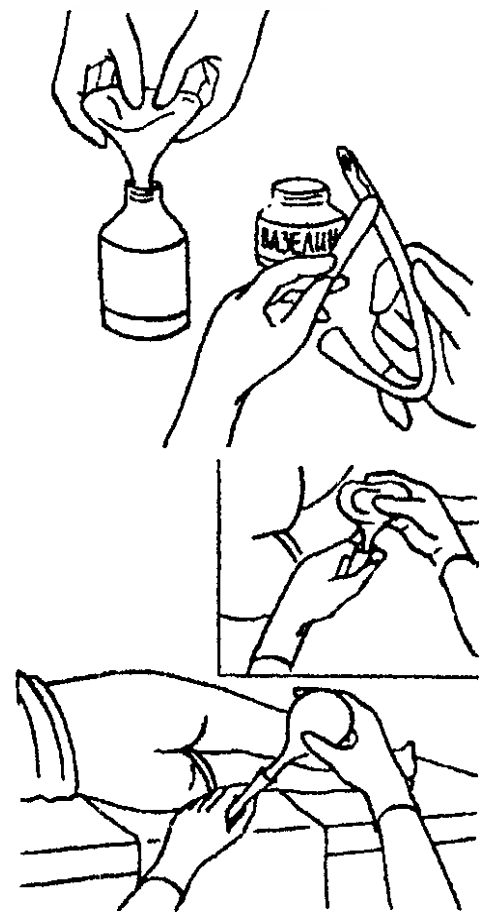
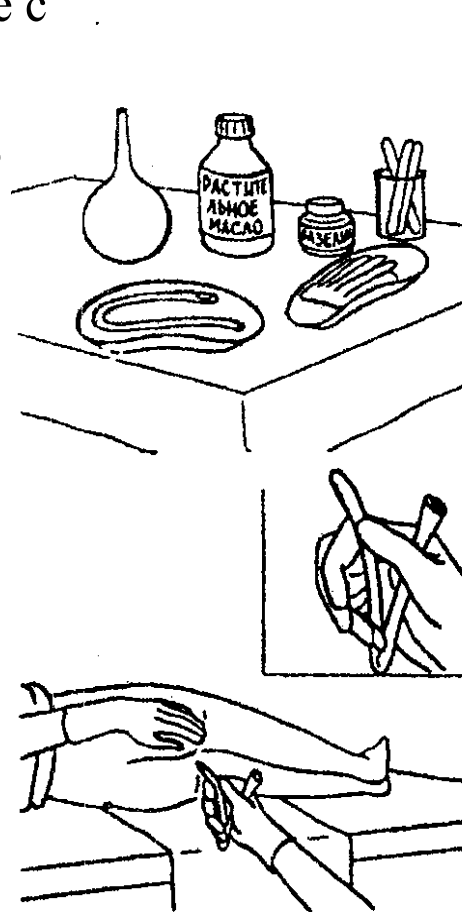


Методика проведения послабляющей клизмы



Необходимое оснащение:

- ▶ специальный резиновый грушевидный баллон (спринцовка) или шприц Жане с резиновой трубкой,
- ▶ 50-100 мл подогретого назначенного вещества (гипертонический раствор, масло или эмульсия),
- ▶ термометр,
- ▶ таз,
- ▶ клеёнка с пелёнкой,
- ▶ салфетка,
- ▶ лубрикант
- ▶ емкости с дезинфицирующими растворами.



Диагностическая (контрастная) клизма



- ▶ Диагностическую клизму (контрастную) используют для определения ёмкости толстой кишки и введения в кишечник рентгеноконтрастного препарата (взвеси сульфата бария) при некоторых методах рентгенологического исследования.
- ▶ Двойное контрастирование кишечника используется для оценки внутренней поверхности толстой кишки.
- ▶ Введение необходимого количества взвеси сульфата бария с последующим раздуванием кишки воздухом.



Ирригоскопия



- ▶ методика исследования, при которой осуществляют ретроградное заполнение толстой кишки контрастным препаратом содержащим сульфат бария.



Лекарственная клизма



- ▶ Лекарственные клизмы способствуют уменьшению явлений раздражения, воспаления в толстой кишке; устраняют спастическое состояние определенного участка кишечника, вызывают заживление эрозий, изъязвлений
- ▶ Многие вещества, вводимые в прямую кишку, хорошо всасываются из нее, преимущественно через нижние геморроидальные вены, попадая непосредственно в нижнюю полую вену, минуя печень
- ▶ За 20-30 мин до лекарственной клизмы больному ставят очистительную.
- ▶ Лекарственный раствор подогревают до температуры 37-39 °С и медленно вводят 50-100 мл.
- ▶ После клизмы больной должен лежать не менее 1 часа

Питательная клизма



- ▶ Применение питательных клизм ограничено, поскольку в нижнем отрезке кишечника всасываются только вода, физиологический раствор, раствор глюкозы, спирт и в минимальной степени аминокислоты.
- ▶ Питательная клизма – лишь дополнительный метод введения питательных веществ.
- ▶ Показания: нарушение акта глотания, непроходимость пищевода, тяжёлые острые инфекции, интоксикации и отравления.
- ▶ Противопоказания: общие абсолютные противопоказания для всех видов клизм.
- ▶ Если вводят небольшое количество раствора (до 200 мл), питательную клизму ставят 1-2 раза в сутки. Раствор должен быть подогрет до температуры 39-40 °С.
- ▶ Порядок выполнения процедуры не отличается от постановки лекарственной клизмы.

Микроклизмы



- ▶ Механизм действия слабительных микроклизм заключается в пептизации каловых масс, то есть их расщеплении на первичные частицы под действием специальных веществ – пептизаторов.
- ▶ ПРИМЕР – Мирколакс. Пептизатор - натрия цитрат. Он вытесняет связанную воду, содержащуюся в каловых массах, что способствует их выведению из кишечника.
- ▶ Компоненты препарата разжижают содержимое кишечника, усиливают слабительное действие путем стимуляции поступления воды в кишечник.
- ▶ Вводить содержимое одной микроклизмы (5 мл) ректально, вставляя наконечник на всю длину у взрослых, у детей до 3 лет – вводить содержимое вставляя наконечник на половину длины



Особенности у детей



Количество жидкости,
необходимое для очистительной клизмы

Возраст ребенка	Количество воды в мл
До 1 мес.	30–50
До 3 мес.	60–70
До 6 мес.	80–90
6–9 мес.	120–150
9–12 мес.	180
1–2 года	200–220
2–5 лет	300–350
6–9 лет	400–500

- до 6 мес – 15 мл на 1 кг массы тела;
- с 6 мес и до 1 года – 20 мл на 1 кг массы тела;
- дети 1 года и более – 30 мл на 1 кг массы тела

НЕ более 1000 мл за одно введение.

